DIABETES FACT SHEET IN KOREA 2025

SPECIAL EDITION

OBESITY & PREGNANCY

Korean Diabetes Association

인사말

대한당뇨병학회는 2012년 Diabetes Fact Sheet in Korea (DFS)를 시작으로 2025년까지 꾸준히 발표해왔습니다.

대한당뇨병학회의 DFS는 국민건강영양조사와 국민건강보험공단의 자료를 기반으로 당뇨병 환자의 규모나 당뇨병 관리실태에 대한 정확한 통계를 제시하고, 동반질환이나 합병증의 심각성을 객관적으로 알리기 위해 제작되었습니다. 또한, 단순히 학술연구의 차원을 벗어나 당뇨병 극복을 위한 대책을 세우고 활발하게 논의를 촉진하는데 중요한 의미가 있는 소중한 자료입니다.

작년에 발표된 DFS 2024 에서는 당뇨병의 유병률, 동반질환 및 청년과 노인 당뇨병의 현황에 대해 발표했으며, 올해 DFS 2025에서는 특별히 1) 당뇨병과 비만, 2) 임신중당뇨병을 집중적으로 다루었습니다. 우리나라에서 지속적으로 늘어나고 있는 비만이 동반된 당뇨병과 임신중당뇨병에 대한 DFS 2025 가 통합적이고 적극적인 관리 방안을 마련하는데 기여하기를 기대합니다.

대한당뇨병학회는 앞으로도 우리나라의 당뇨병 예방 및 관리수준을 높이고, 나아가 당뇨병 극복을 위해 최선을 다할 것입니다. DFS 2025가 이 목표를 위해 도움이 될 귀중한 자료로 활용되기를 바랍니다.

대한당뇨병학회 회장 **안규정**

대한당뇨병학회 이사장 **차봉수**

임원진 (2025)

Korean Diabetes Association

회장	**안규정**	경희의대
부회장	**박강서**	을지의대
	조영중	국립중앙의료원
	김혜련	계명대학교 동산병원
	이지현	아주대학교병원
감사	**박석원**	연세의대
	홍영선	이화의대
이사장	**차봉수**	연세의대
총무이사	**이용호**	연세의대
학술이사	**김신곤**	고려의대
간행이사	**권혁상**	가톨릭의대
교육이사	**문민경**	서울의대
수련이사	**고관표**	제주의대
연구이사	**조동혁**	전남의대
진료지침이사	**이병완**	연세의대
식품영양이사	**김상수**	부산의대
보험이사	**김수경**	차의과학대
법제이사	**조영민**	서울의대
홍보이사	**최성희**	서울의대
정보이사	**강은석**	연세의대
국제협력이사	**김소헌**	인하의대

환자관리이사	**진흥용**	전북의대
기획이사	**이재혁**	명지병원
일차진료이사	**한정훈**	프렌닥터한내과의원
윤리이사	**송기호**	건국의대
사회공헌이사	**박석오**	박샘내과의원
재무이사	**문준성**	영남의대
췌도부전당뇨병TFT	**김재현**	성균관의대
청년당뇨병/임신중당뇨병TFT	**곽수헌**	서울의대
비만당뇨병TFT	**이승환**	가톨릭의대
노인당뇨병TFT	**조동혁**	전남의대
무임소이사	**이대호**	가천의대
	구본정	충남의대
	안철우	연세의대
	윤석기	천안엔도내과의원
	박근규	경북의대
	원종철	인제의대

출판인	**차봉수**
편집인	**최성희**
편집위원	**고승현, 김진화, 문준호, 박세은, 이승환, 정한나, 한경도**

목차

PART 1
당뇨병과 비만

Ⅰ. 당뇨병과 비만

10 당뇨병 환자의 비만동반율
11 연령대별 당뇨병 환자의 비만 동반율
13 당뇨병 환자의 복부비만 동반율
14 연령대별 당뇨병 환자의 복부비만 동반율

Ⅱ. 당뇨병 환자의 비만 변화

17 당뇨병 환자의 비만, 복부비만 동반율 변화
20 당뇨병 환자의 체질량지수와 허리둘레 변화

Ⅲ. 비만과 비비만 당뇨병

24 유병률 / 연령대별 유병률 / 유병률 변화
30 당뇨병전단계: 유병률 / 연령대별 유병률
34 혈당조절상태
36 동반질환: 고혈압 / 고콜레스테롤혈증
40 통합관리
42 당뇨병약물 처방 현황

Ⅳ. 비만대사수술 현황과 비만 당뇨병의 예후

45 비만대사수술 건수
46 비만대사수술 방법 현황
47 당뇨병 환자의 비만 단계별 암 발생 위험

PART 2
당뇨병과 임신

Ⅰ. 임신중당뇨병 유병률

52 임신당뇨병 및 임신전당뇨병 유병률
53 임신당뇨병 유병률
54 임신전당뇨병 유병률

Ⅱ. 산모의 임상적 특성

56 출산연령 변화
57 임신전 체질량지수 변화
58 임신전 허리둘레 변화
59 임신전 공복혈당 변화

Ⅲ. 임신중당뇨병의 혈당관리 방법

61 임신중당뇨병의 혈당관리 방법

Ⅳ. 임신중당뇨병의 위험요인

63 연령에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
64 소득에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
65 체질량지수에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
66 허리둘레에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
67 공복혈당에 따른 임신당뇨병 유병률
68 임신전 고혈압에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
69 임신전 이상지질혈증에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

Ⅴ. 임신중당뇨병 산모의 출산후 당뇨병 추적관리 및 합병증

71 출산후 당뇨병 추적검사 시행률
73 출산후 2형당뇨병 및 심뇌혈관질환 발생위험

PART 1
당뇨병과 비만

DIABETES FACT SHEET
IN KOREA 2025

자료원 및 정의 (국민건강영양조사)

국민건강영양조사 2012-2023년 (비만 현황: 2022-2023년 통합)
대상: 19세 이상 성인

비만 정의	비만 (체질량지수 기준)(kg/m^2)	①<18.5 저체중 ② 18.5-22.9 정상체중 ③ 23.0-24.9 비만전단계 (과체중) ④ 25.0-29.9 1단계 비만 ⑤ 30.0-34.9 2단계 비만 ⑥ ≥35.0 3단계 비만
	복부비만 (허리둘레 기준)	남자 90 cm 이상, 여자 85 cm 이상
당뇨병 및 당뇨병전단계 정의	당뇨병	4개 중 하나 이상에 해당되는 경우 ①의사로부터 당뇨병을 진단받은 경우 ②당뇨병약물로 치료 중인 경우 ③공복혈당이 126 mg/dL 이상인 경우 ④당화혈색소가 6.5% 이상인 경우
	당뇨병전단계	당뇨병이 아니면서 공복혈당이 100-125 mg/dL 또는 당화혈색소 5.7-6.4%인 경우
당뇨병 동반질환	고혈압 유병률	수축기혈압이 140 mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90 mmHg 이상 또는 고혈압약물를 복용한 분율
	고혈압 조절률	수축기혈압이 140 mmHg 미만이고 이완기혈압이 85 mmHg 미만인 분율
	고콜레스테롤혈증 유병률	혈중 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율
	고콜레스테롤혈증 조절률	혈중 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 미만인 분율
	통합관리	당화혈색소 6.5% 미만, 혈압 140/85 mmHg 미만, LDL 콜레스테롤 100 mg/dL 미만의 세 가지 목표에 모두 도달한 경우

자료원 및 정의 (국민건강보험공단)

자료원	당뇨병약물 처방	2022년 건강검진 대상자 중 20세 이상 2형당뇨병 환자, 맞춤형 DB (10% sampling)
	비만대사수술	2022년 맞춤형 DB (10% sampling)
	암 발생 위험	2015-2016년 건강검진 대상자 중 30세 이상 2형당뇨병 환자, 2023년 12월 31일까지 추적관찰
정의	2형당뇨병	ICD-10 상병코드 E11-14와 함께 당뇨병약물이 청구 되었거나 공복혈당 126 mg/dL 이상인 경우
	비만대사수술	소매위절제: Q2630 / 루Y모양위우회술: Q2633, Q2634, Q2635, Q2636 / 십이지장전환술: Q2637 / 조절형위밴드술: Q2638 / 교정수술: QA630, QA633, QA634, QA635, QA636, QA637, QA638의 코드로 청구된 경우
	암	ICD-10 상병코드 C00-98과 희귀질환 산정특례코드 V193(등록 암환자)이 함께 청구된 경우 갑상선암: C73 / 폐암: C33, C34 / 위암: C16 / 대장암: C18, C19 / 유방암: C50 / 전립선암: C61 / 간암: C22 / 췌장암: C25 / 담낭 및 기타 담도암: C23, C24 / 신장암: C64

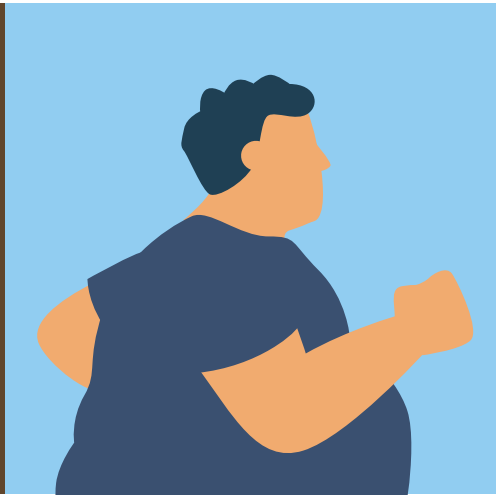
각 위험비는 나이, 성별을 보정한 콕스 비례위험모형을 이용하여 제시함.
ICD-10: International Classification of Diseases, 10th Revision

당뇨병과 비만

OBESITY

I

당뇨병 환자의 비만동반율
연령대별 당뇨병 환자의 비만 동반율
당뇨병 환자의 복부비만 동반율
연령대별 당뇨병 환자의 복부비만 동반율



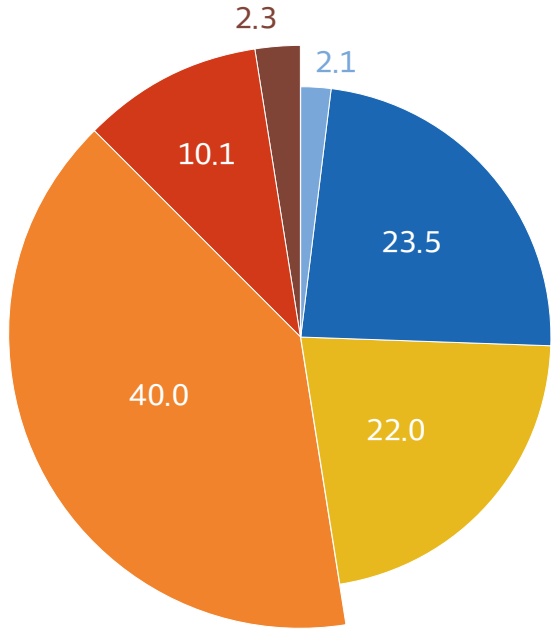
당뇨병 환자의 비만동반율

당뇨병 환자의 절반 (52.4%)에서 비만이 동반되었으며, 2단계 이상 비만은 12.4%였음.
체질량지수 35 kg/m² 이상의 3단계 비만은 2.3%였음.

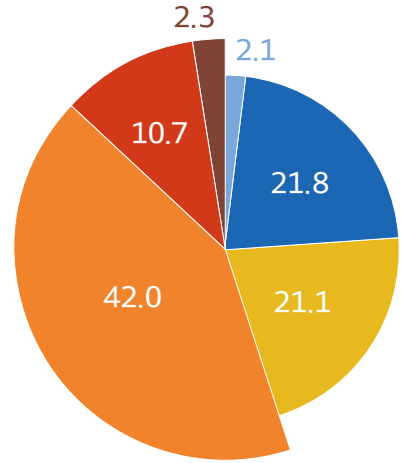
- 저체중 (<18.5)
- 정상 (18.5-22.9)
- 비만전단계 (과체중) (23.0-24.9)
- 1단계 비만 (25.0-29.9)
- 2단계 비만 (30.0-34.9)
- 3단계 비만 (≥35.0)

(kg/m²)

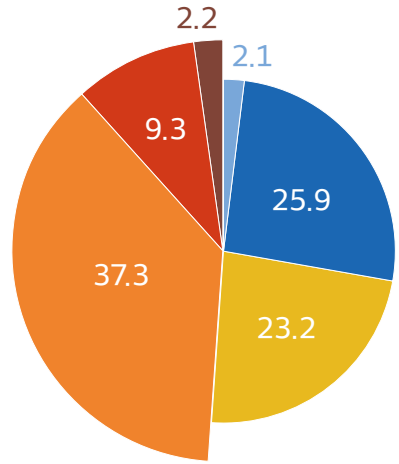
전체
(%)



남성
(%)

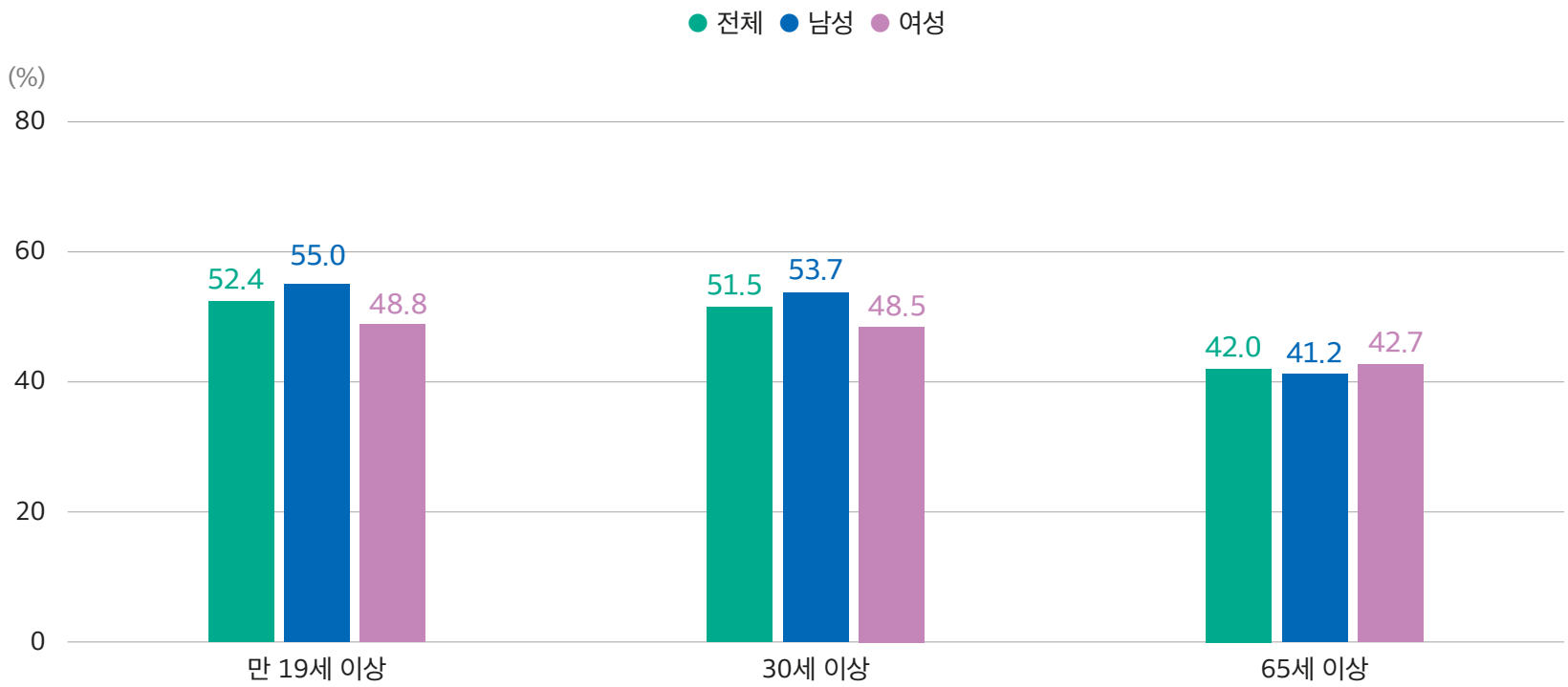


여성
(%)



연령대별 당뇨병 환자의 비만 동반율

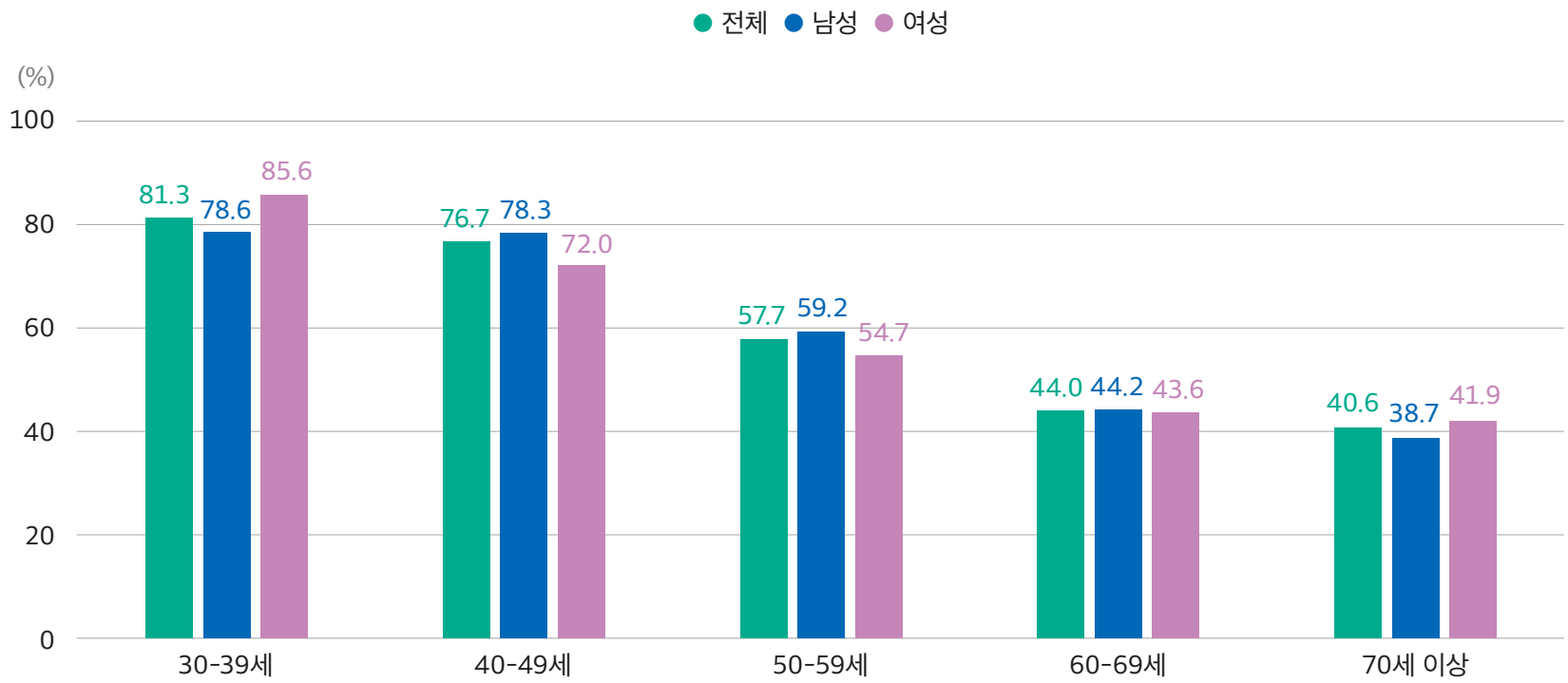
당뇨병 환자의 약 절반이 비만을 동반하며, 남성이 여성보다 그 비율이 높았음.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

연령대별 당뇨병 환자의 비만 동반율

30대와 40대 당뇨병 환자의 비만 동반율은 각각 81.3%, 76.7%로 가장 높았으며,
연령대가 증가하면서 비만 동반율이 낮아짐. 남성과 여성 모두에서 유사한 경향을 보임.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

당뇨병 환자의 복부비만 동반율

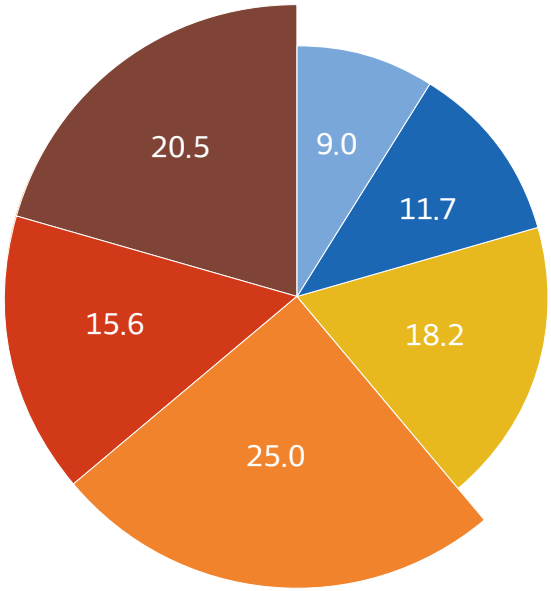
당뇨병 환자의 61.1%가 복부비만을 동반함.

- 남성 <80, 여성 <75
- 남성 81-84, 여성 75-79
- 남성 85-89, 여성 80-84
- 남성 90-94, 여성 85-89
- 남성 95-99, 여성 90-94
- 남성 ≥100, 여성 ≥95

(cm)

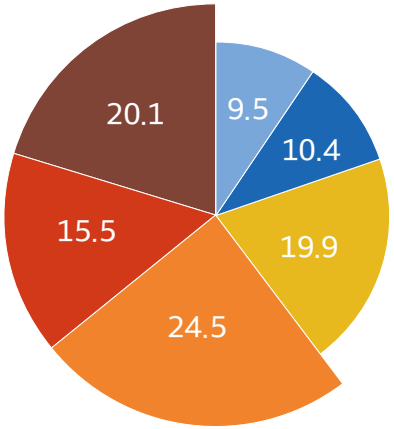
전체

(%)



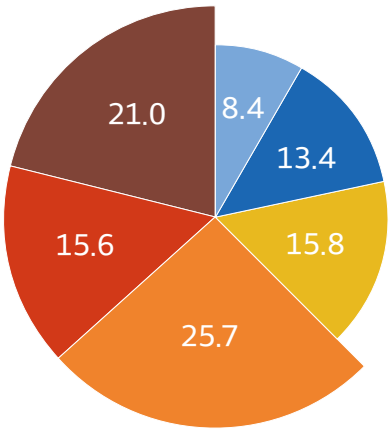
남성

(%)



여성

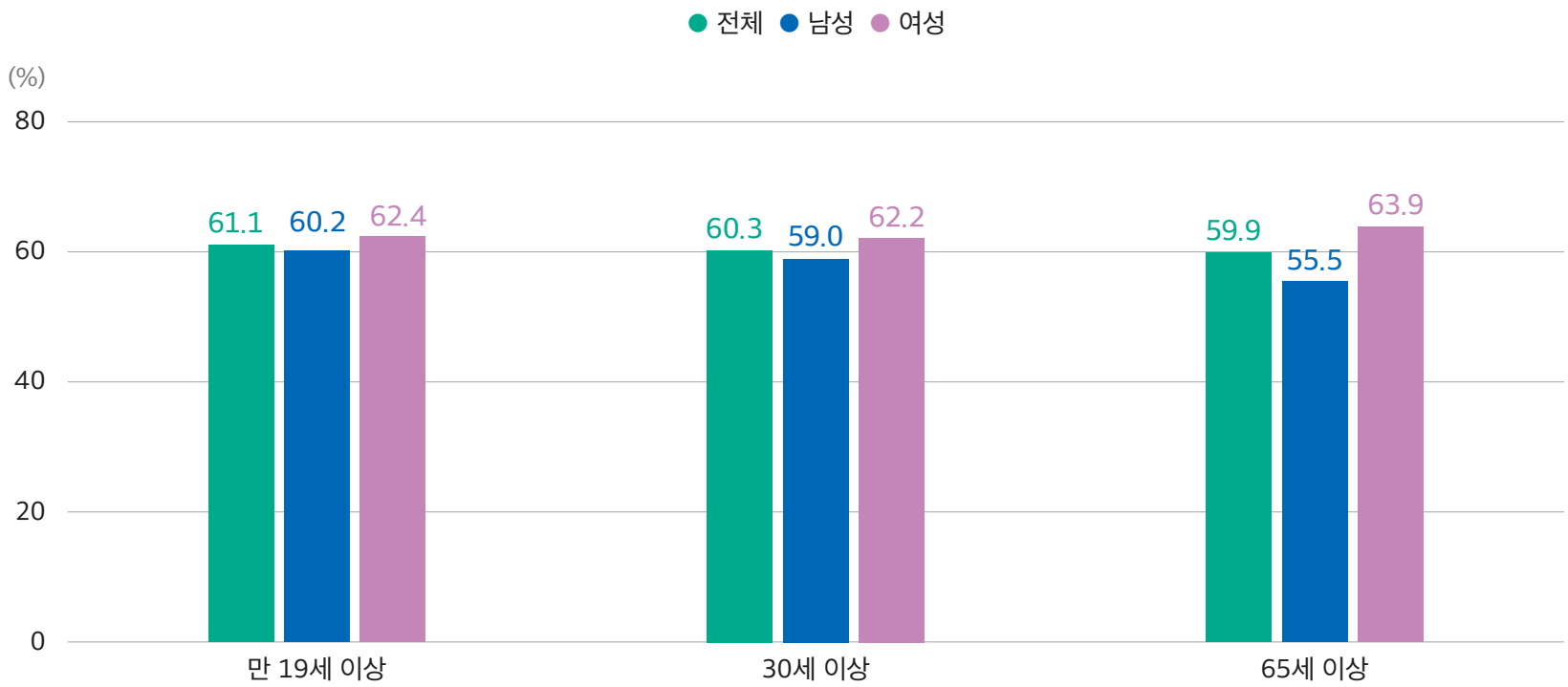
(%)



복부비만 (허리둘레 기준): 남자 90 cm 이상, 여자 85 cm 이상

연령대별 당뇨병 환자의 복부비만 동반율

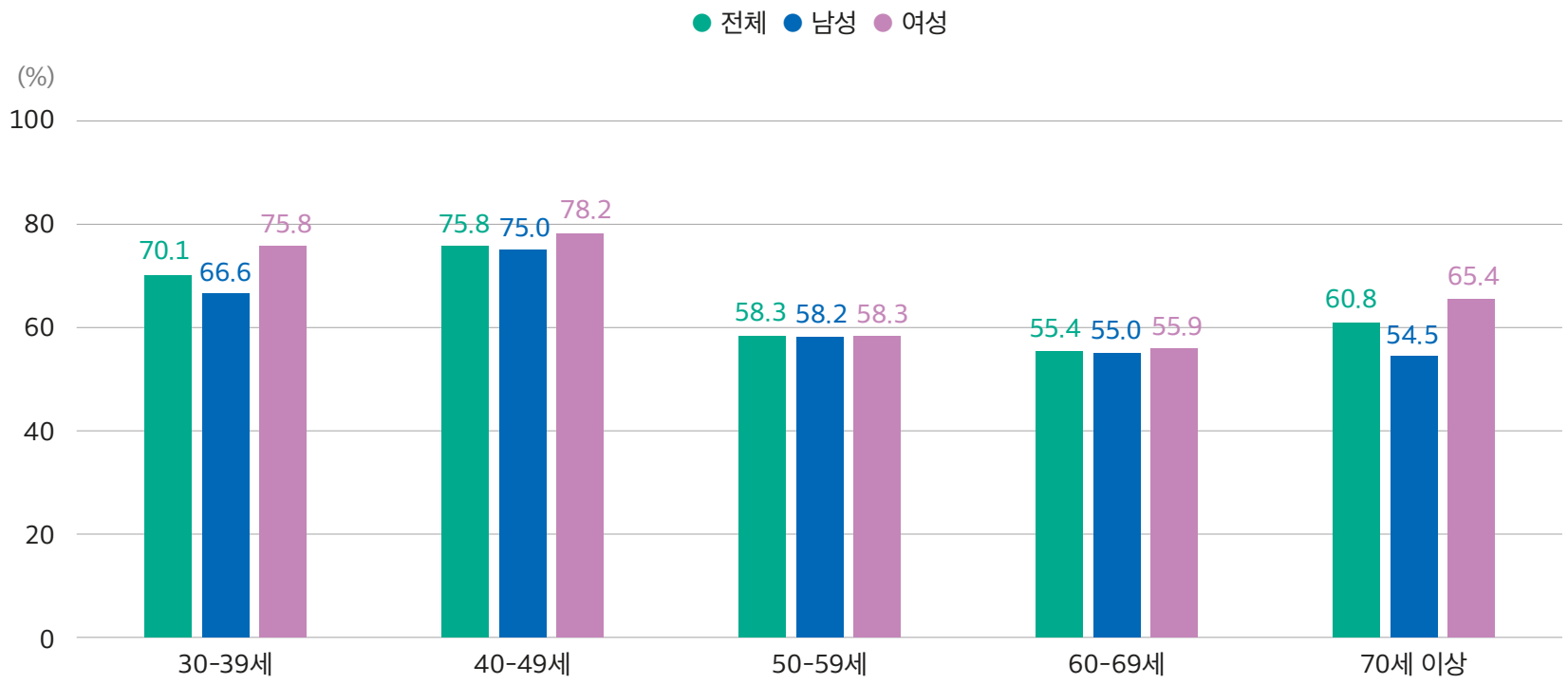
당뇨병 환자의 61.1%가 복부비만을 동반하며, 65세 이상 여성의 복부비만 동반율이 남성보다 두드러짐.



복부비만 (허리둘레 기준): 남성 90 cm 이상 / 여성 85 cm 이상

연령대별 당뇨병 환자의 복부비만 동반율

30대와 40대 당뇨병 환자의 복부비만 동반율은 각각 70.1%, 75.8%로 가장 높았으며,
이후 연령대에서는 점차 낮아지다 70세 이상에서 60%대를 보임. 여성의 복부비만 동반율이 남성보다 높음.



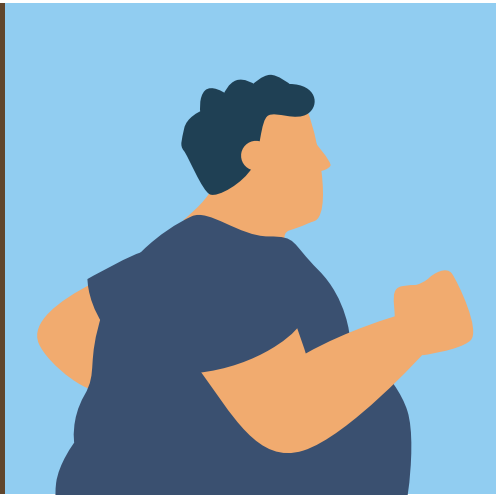
복부비만 (허리둘레 기준): 남성 90 cm 이상 / 여성 85 cm 이상

당뇨병 환자의 비만 변화

당뇨병 환자의 비만, 복부비만 동반율 변화
당뇨병 환자의 체질량지수와 허리둘레 변화

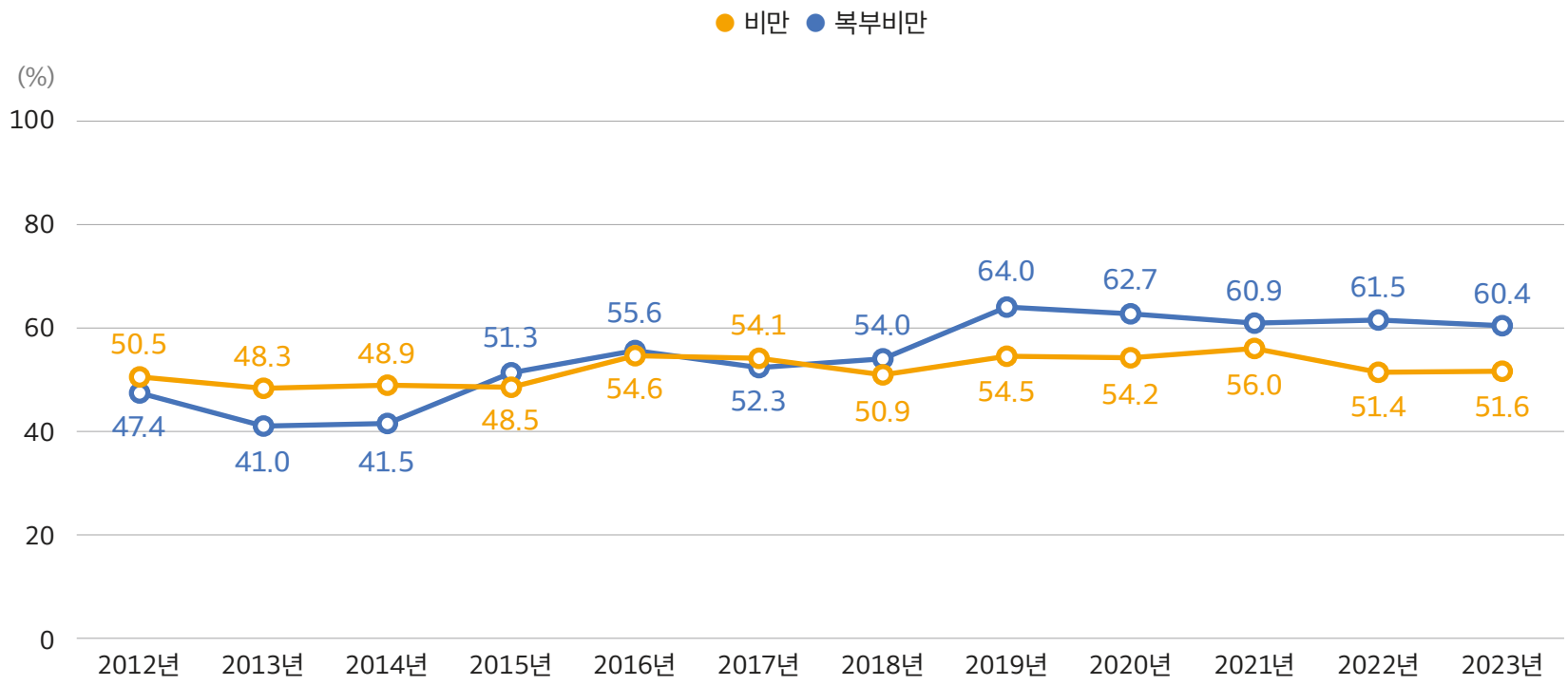
OBESITY

II



당뇨병 환자의 비만, 복부비만 동반율 변화

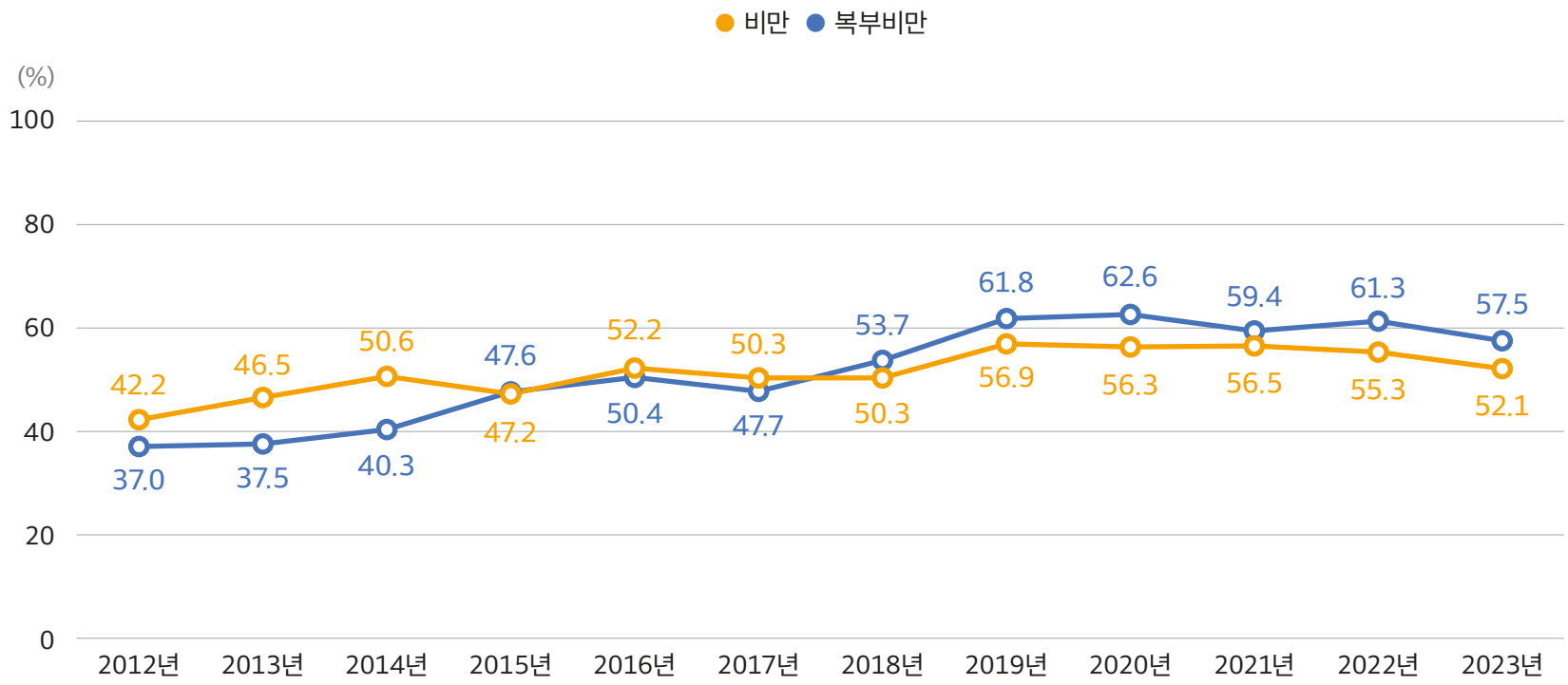
최근 12년간 당뇨병 환자의 절반은 비만을 동반하였으며,
복부비만 동반율은 증가하였다가 최근에는 안정화추세임.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
복부비만 (허리둘레 기준): 남성 90cm 이상 / 여성 85cm 이상

당뇨병 환자의 비만, 복부비만 동반율 변화

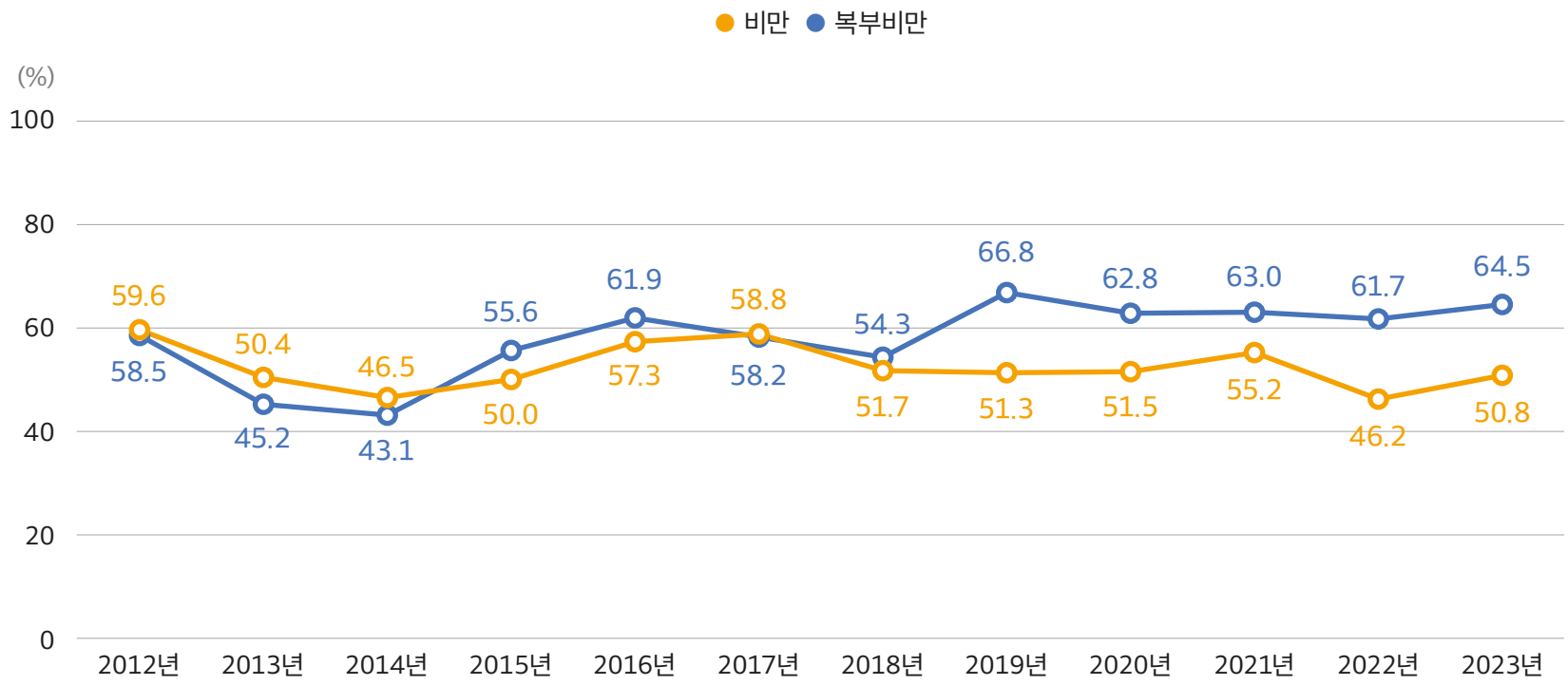
남성은 비만과 복부비만 동반율 모두 증가 추세를 보임.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
복부비만 (허리둘레 기준): 90cm 이상

당뇨병 환자의 비만, 복부비만 동반율 변화

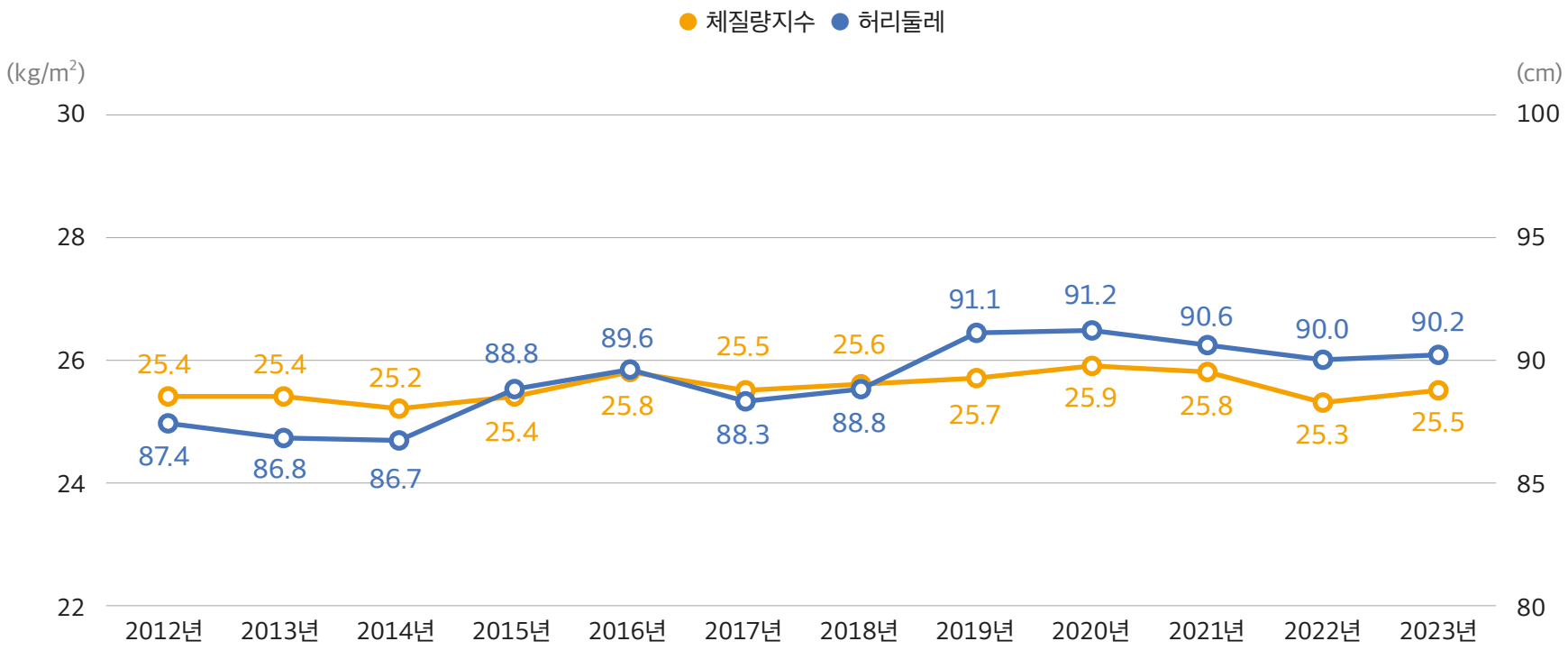
여성은 복부비만 동반율의 증가가 두드러짐.



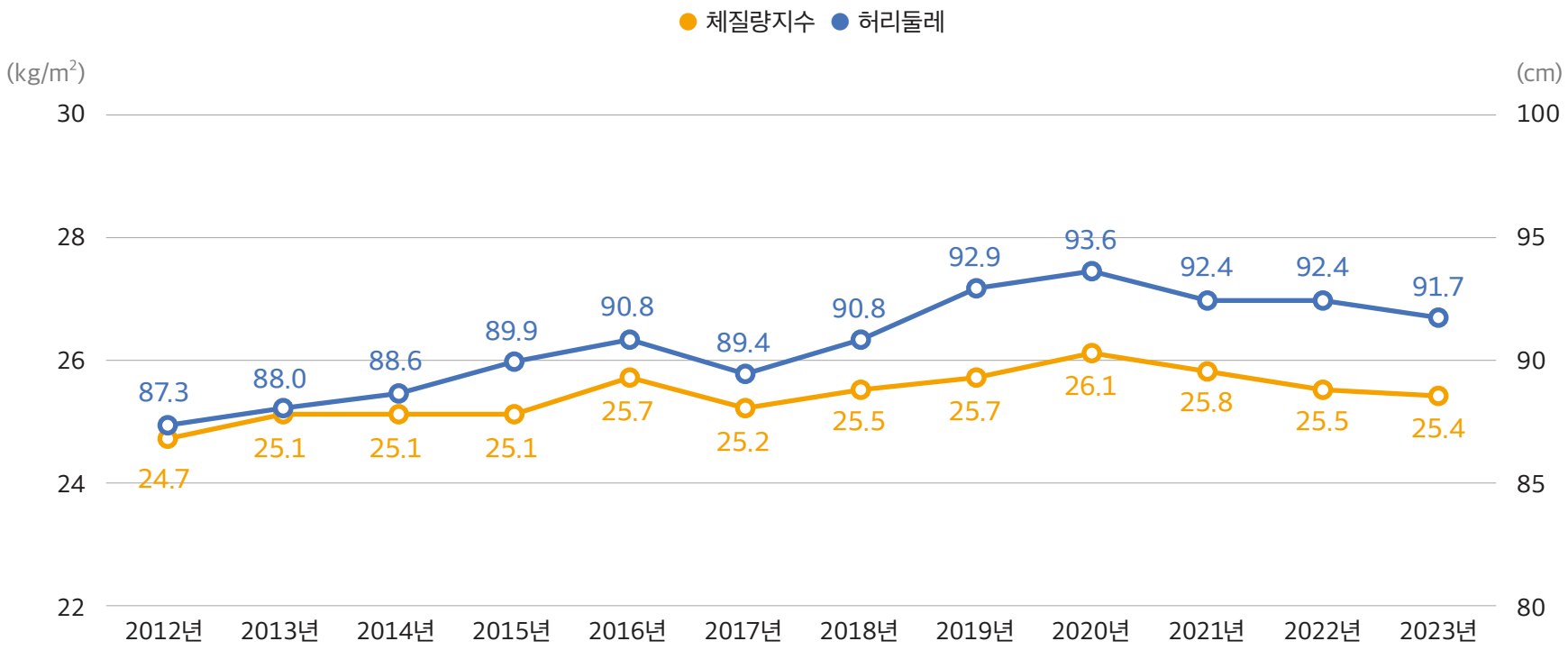
비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
복부비만 (허리둘레 기준): 85cm 이상

당뇨병 환자의 체질량지수와 허리둘레 변화

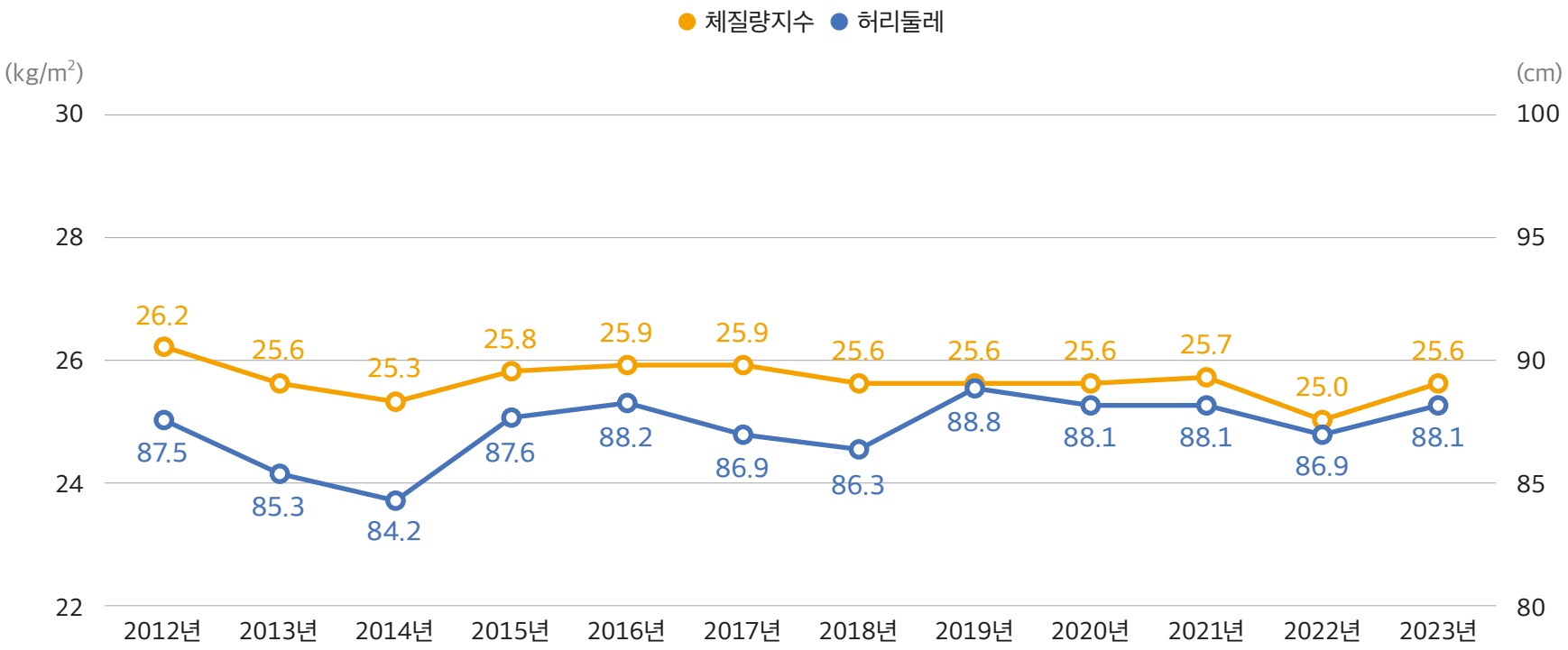
최근 12년간 당뇨병 환자의 체질량지수는 비슷하게 유지되나 허리둘레는 증가하였음



당뇨병 환자의 체질량지수와 허리둘레 변화



당뇨병 환자의 체질량지수와 허리둘레 변화



비만과 비비만 당뇨병

OBESITY

III

유병률 / 연령대별 유병률 / 유병률 변화

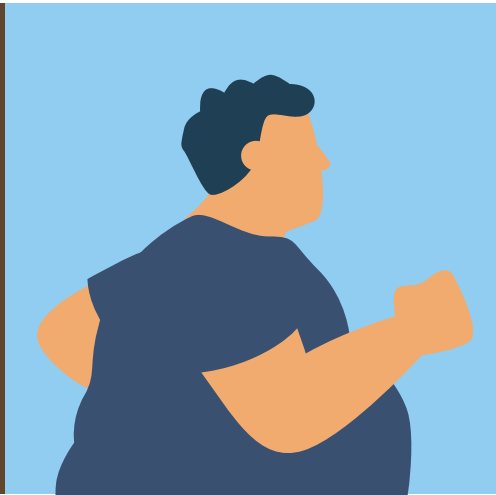
당뇨병 전단계: 유병률 / 연령대별 유병률

혈당조절상태

동반질환: 고혈압 / 고콜레스테롤혈증

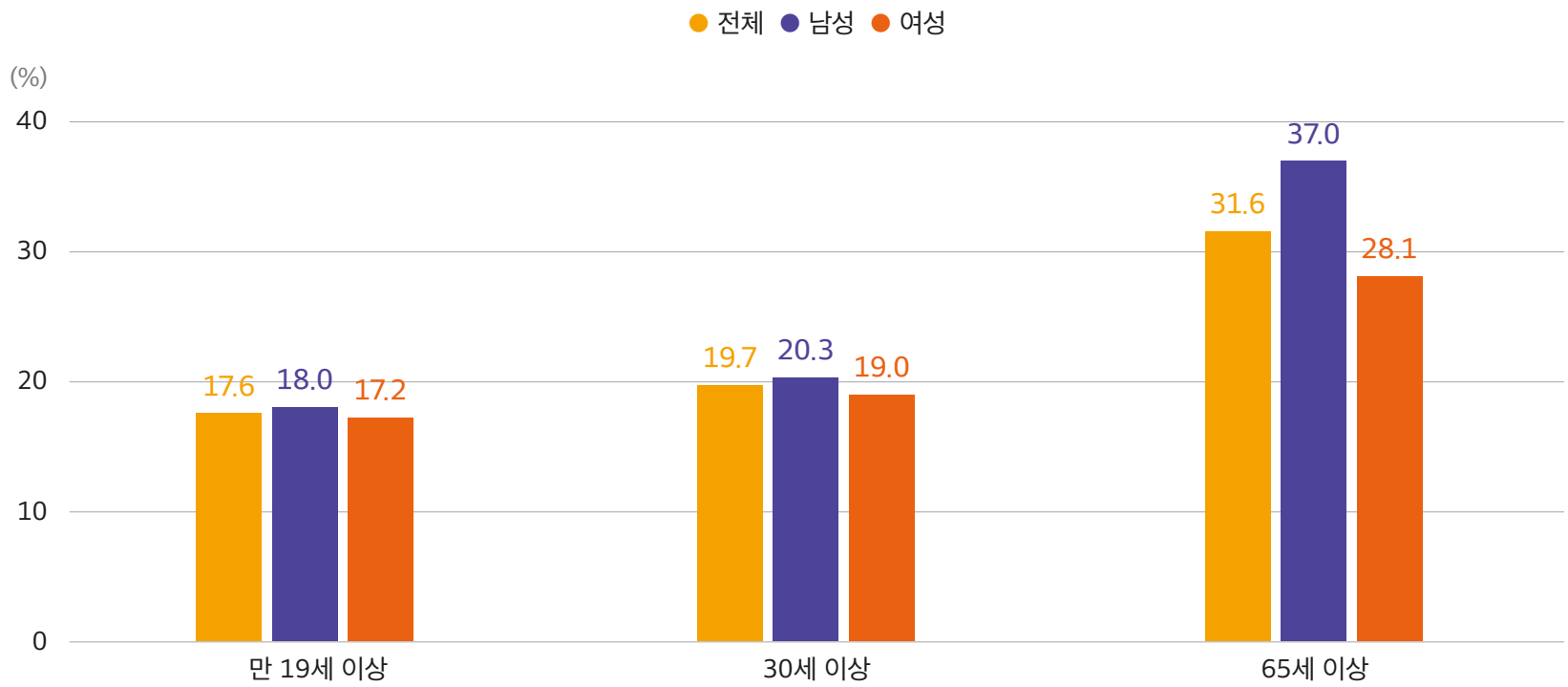
통합관리

당뇨병약물 처방 현황



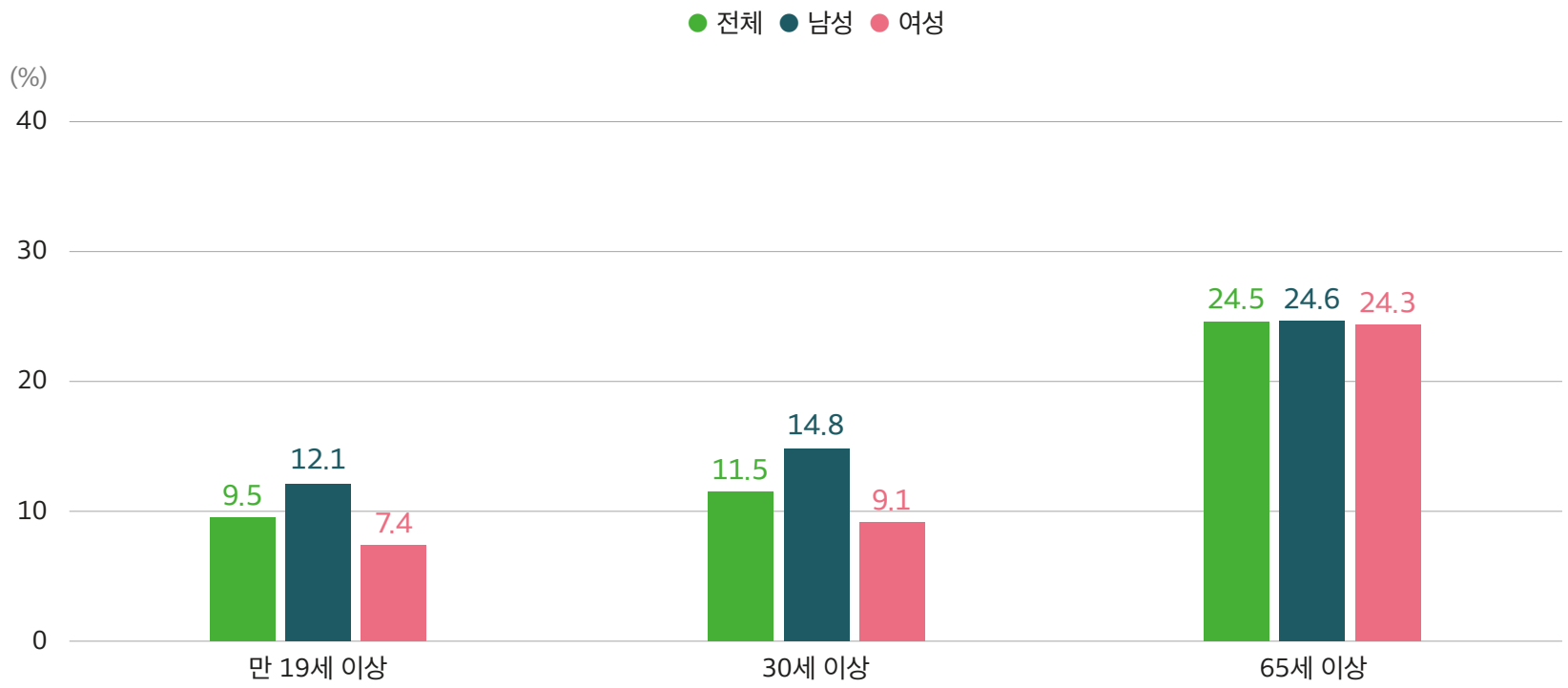
비만 인구의 당뇨병 유병률

비만 인구의 당뇨병 유병률은 17.6% 로 비비만 인구보다 약 2배 높음.
65세 이상 비만 인구의 3명중 1명이 (31.6%) 당뇨병을 동반함.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

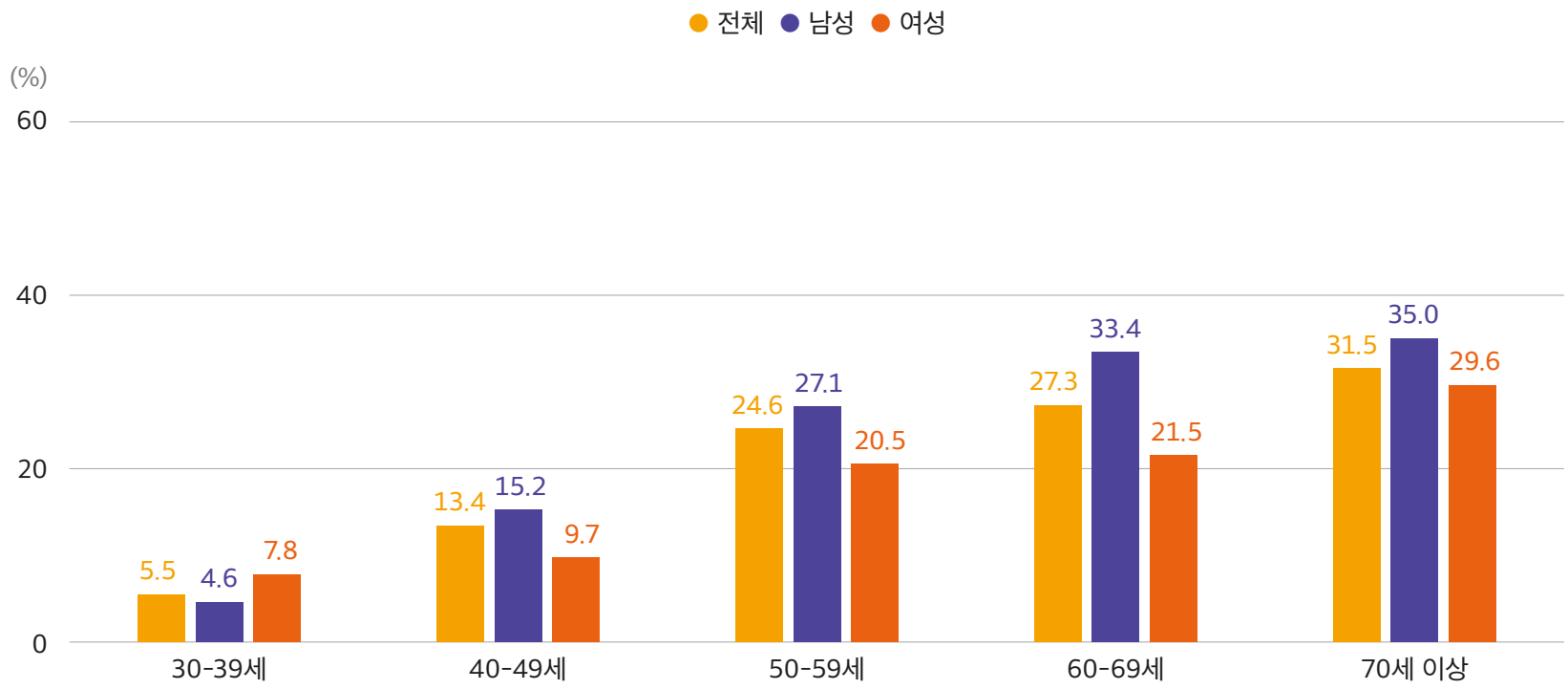
비비만 인구의 당뇨병 유병률



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

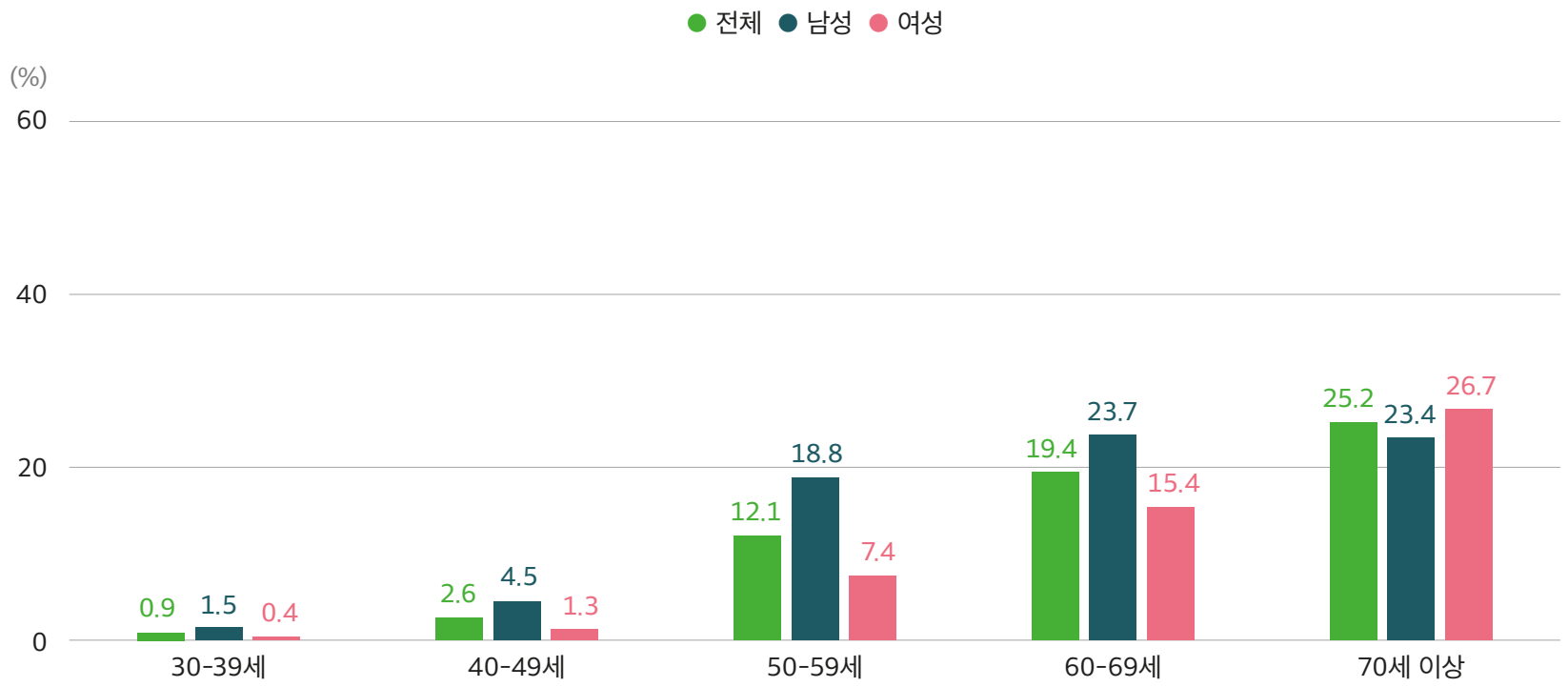
연령대별 비만 인구의 당뇨병 유병률

비만 인구는 비비만 인구보다 모든 연령대에서 당뇨병 유병률이 높음.
특히 30, 40, 50대에서 두 집단 간 격차가 크며, 여성에서 더욱 뚜렷함.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

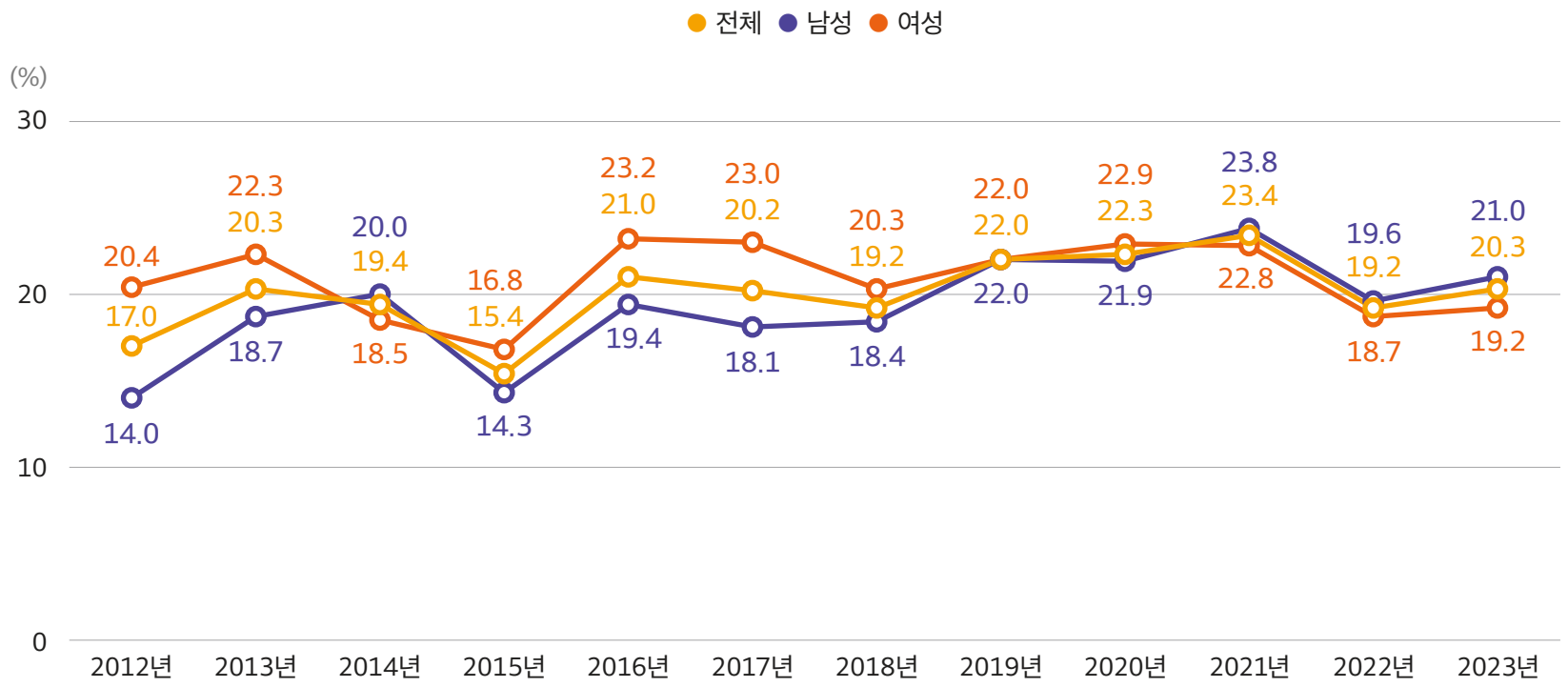
연령대별 비비만 인구의 당뇨병 유병률



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

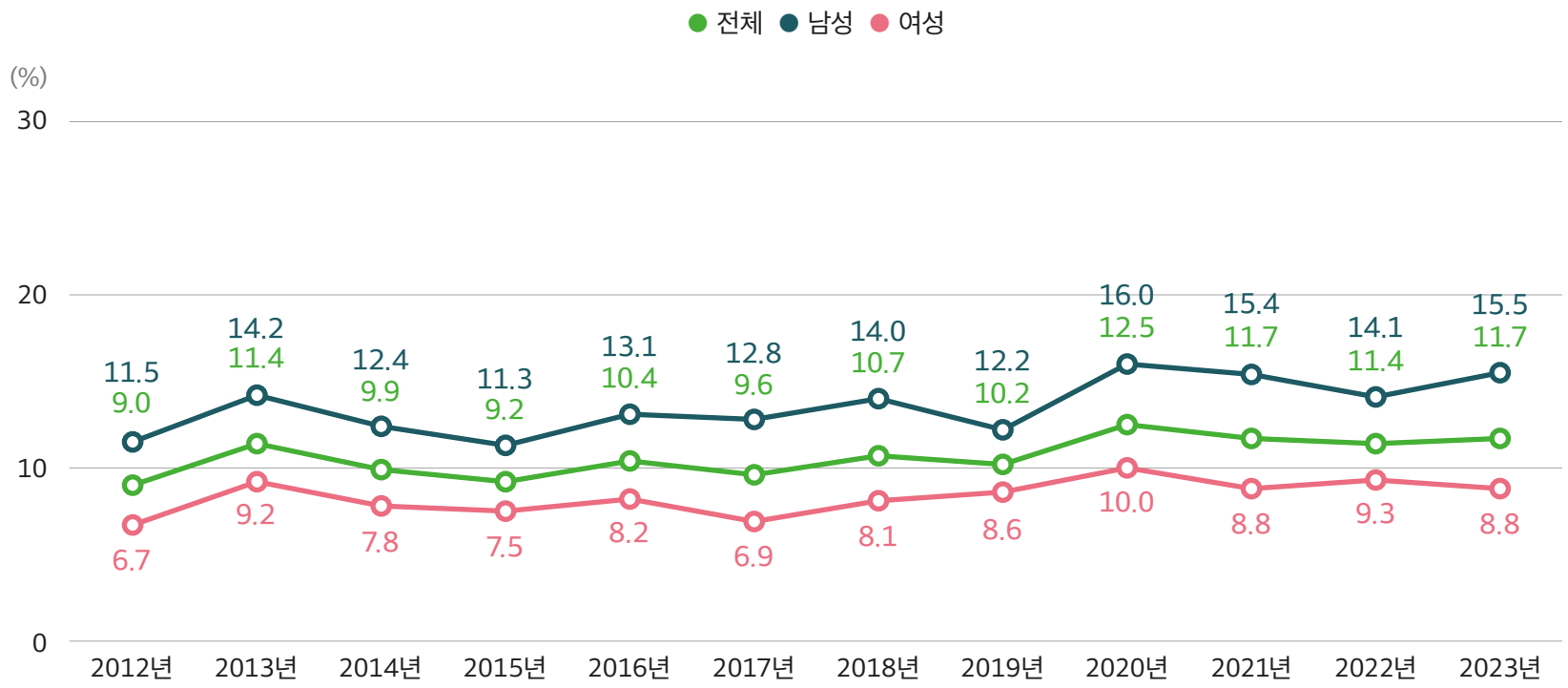
비만 인구의 당뇨병 유병률 변화

최근 12년간 비만 인구는 비비만 인구보다 당뇨병 유병률이 높았으며,
그 격차는 여성에서 더욱 뚜렷함. 남성 비만 인구에서 당뇨병 유병률은 꾸준히 증가함.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

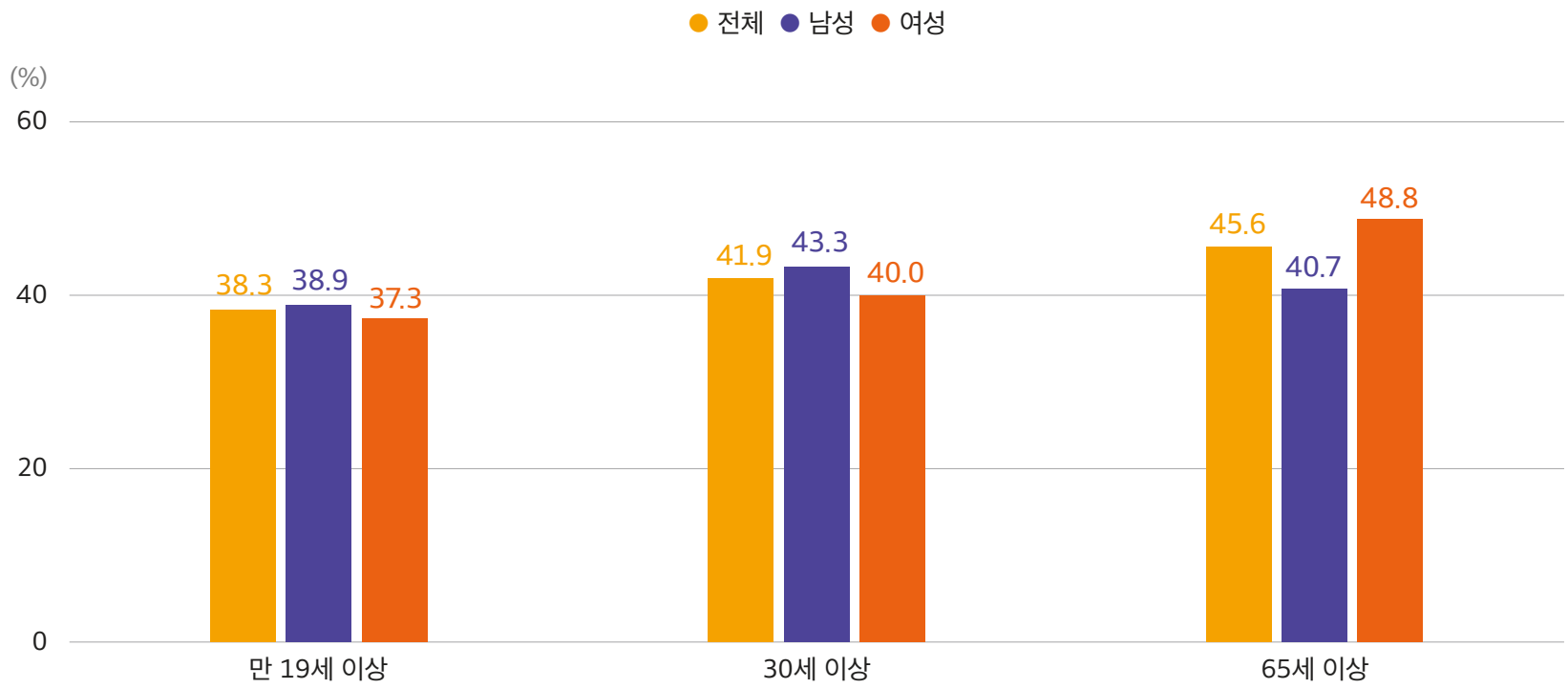
비비만 인구의 당뇨병 유병률 변화



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

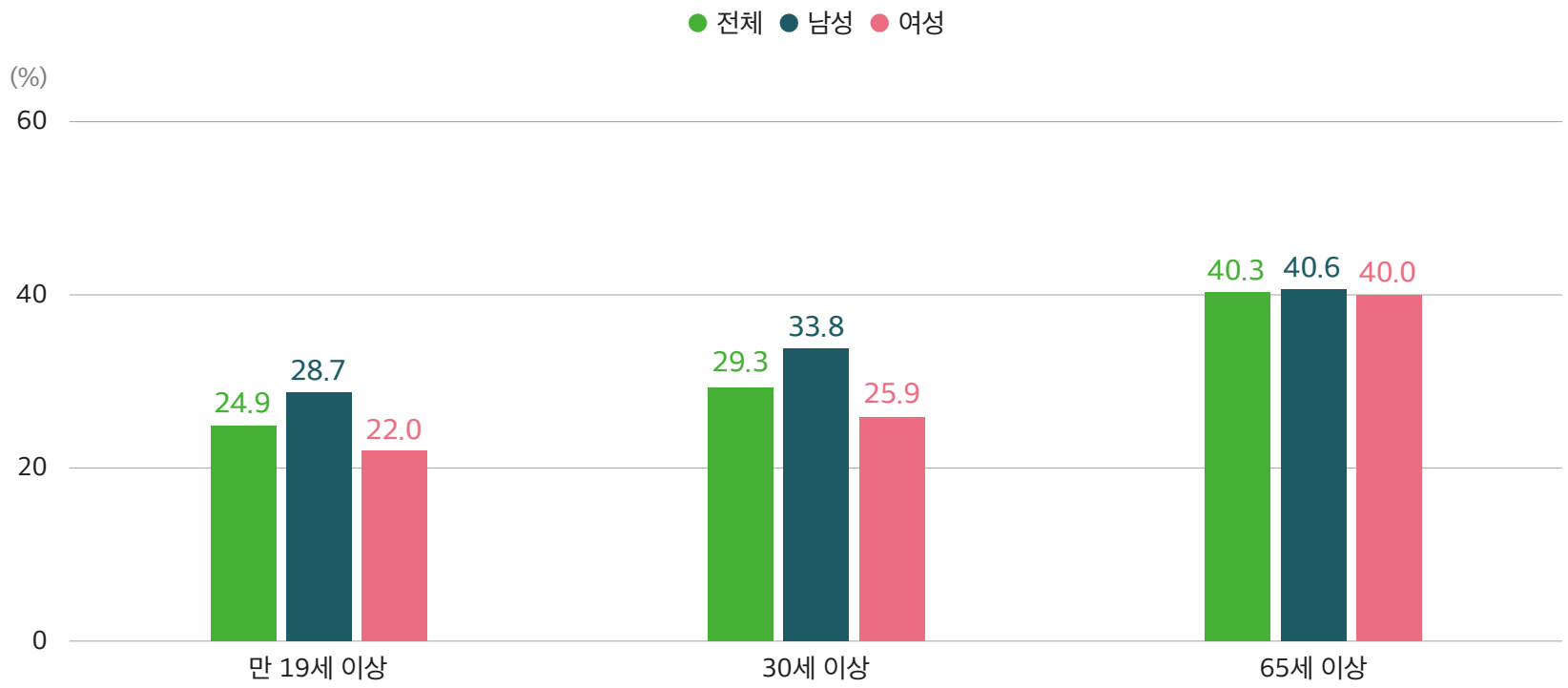
비만 인구의 당뇨병 전단계 유병률

비만인구의 당뇨병 전단계 유병률은 38.3%로 비비만 인구보다 약 1.5배 높음.
65세 이상 비만인구의 약 2명중 1명이 (45.6%) 당뇨병 전단계를 동반함.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

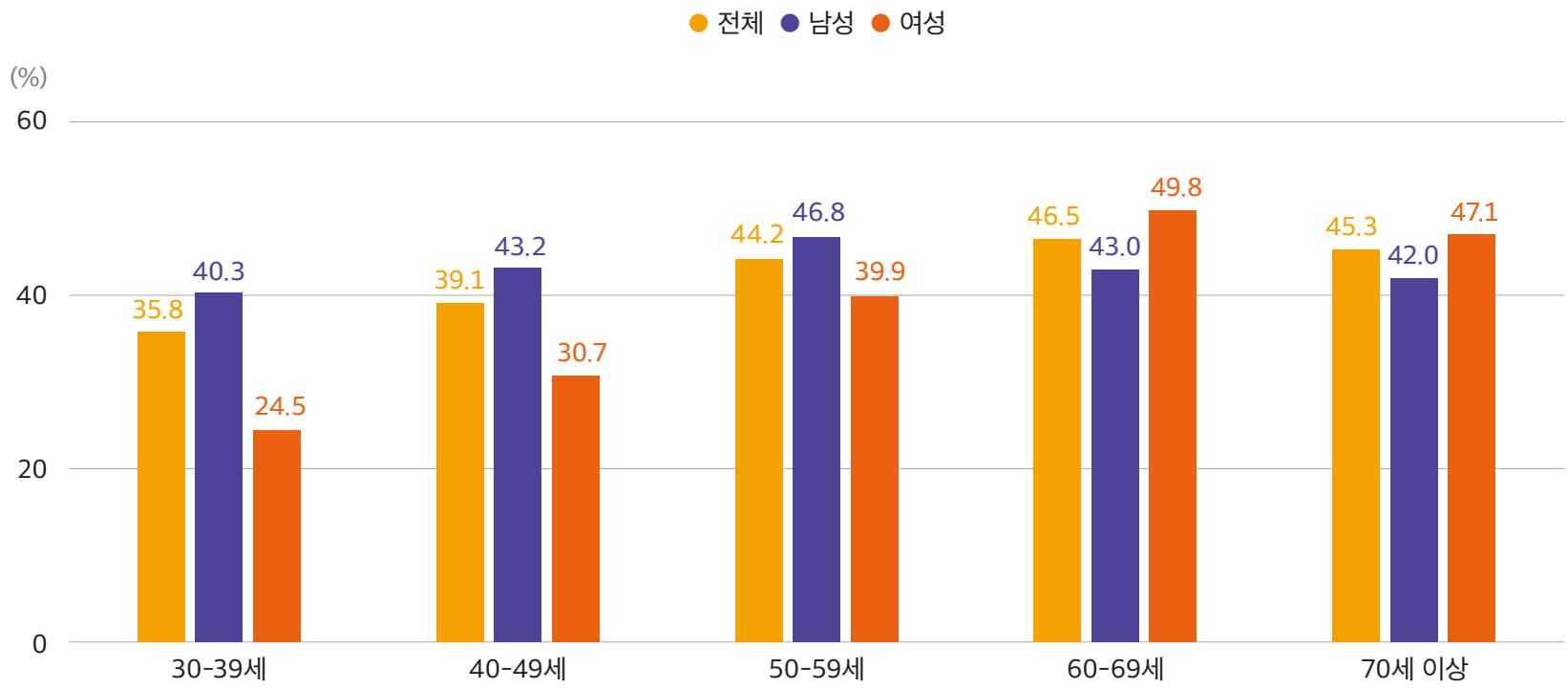
비비만 인구의 당뇨병 전단계 유병률



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

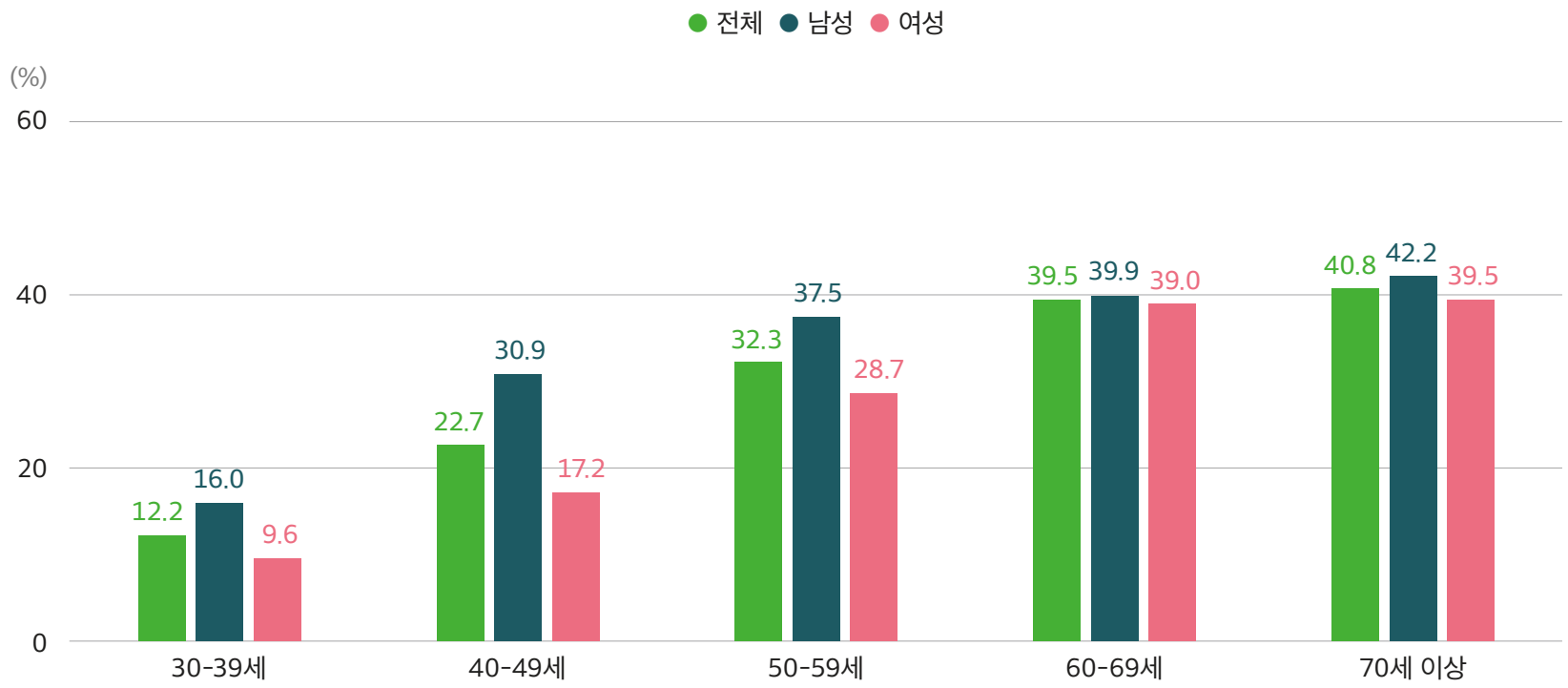
연령대별 비만 인구의 당뇨병 전단계 유병률

비만 인구는 비비만 인구보다 모든 연령대에서 당뇨병 전단계 유병률이 높음.
특히 30, 40, 50대에서 두 집단 간 격차가 큼.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

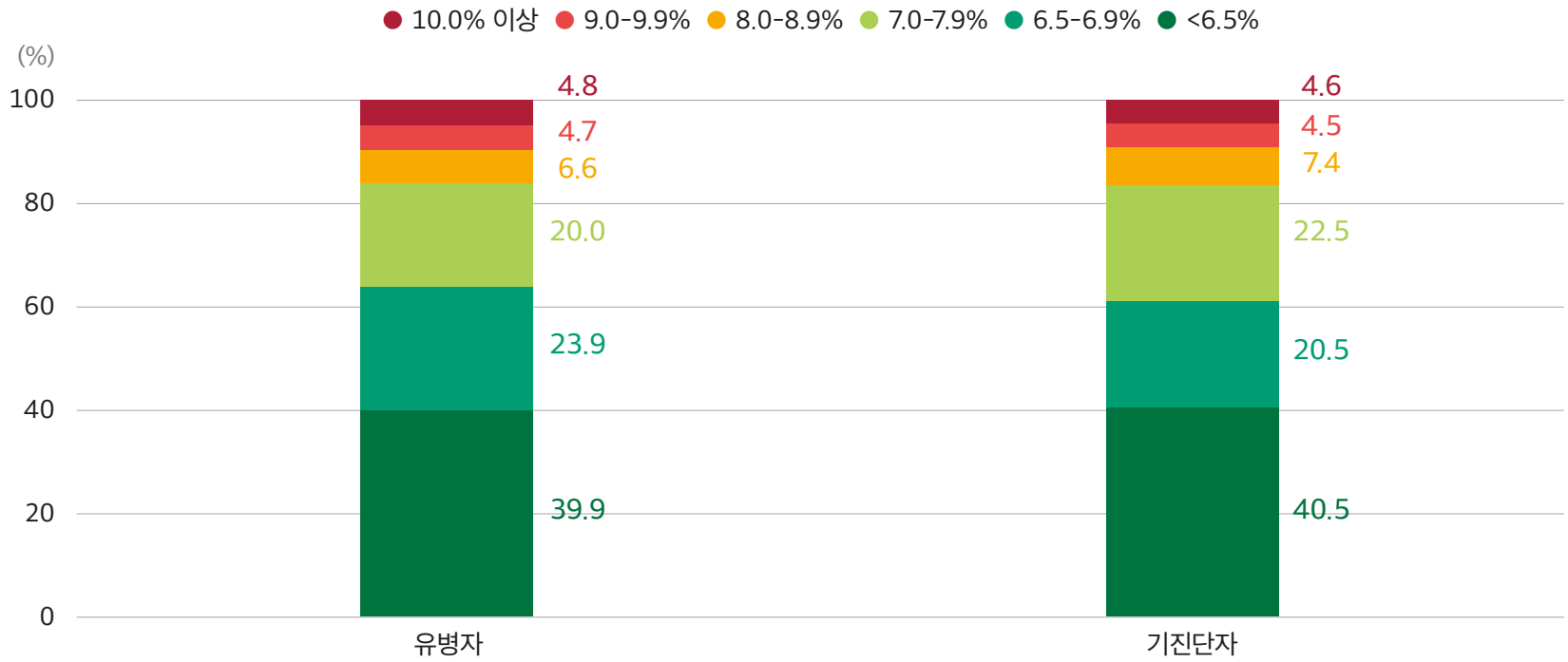
연령대별 비비만 인구의 당뇨병 전단계 유병률



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

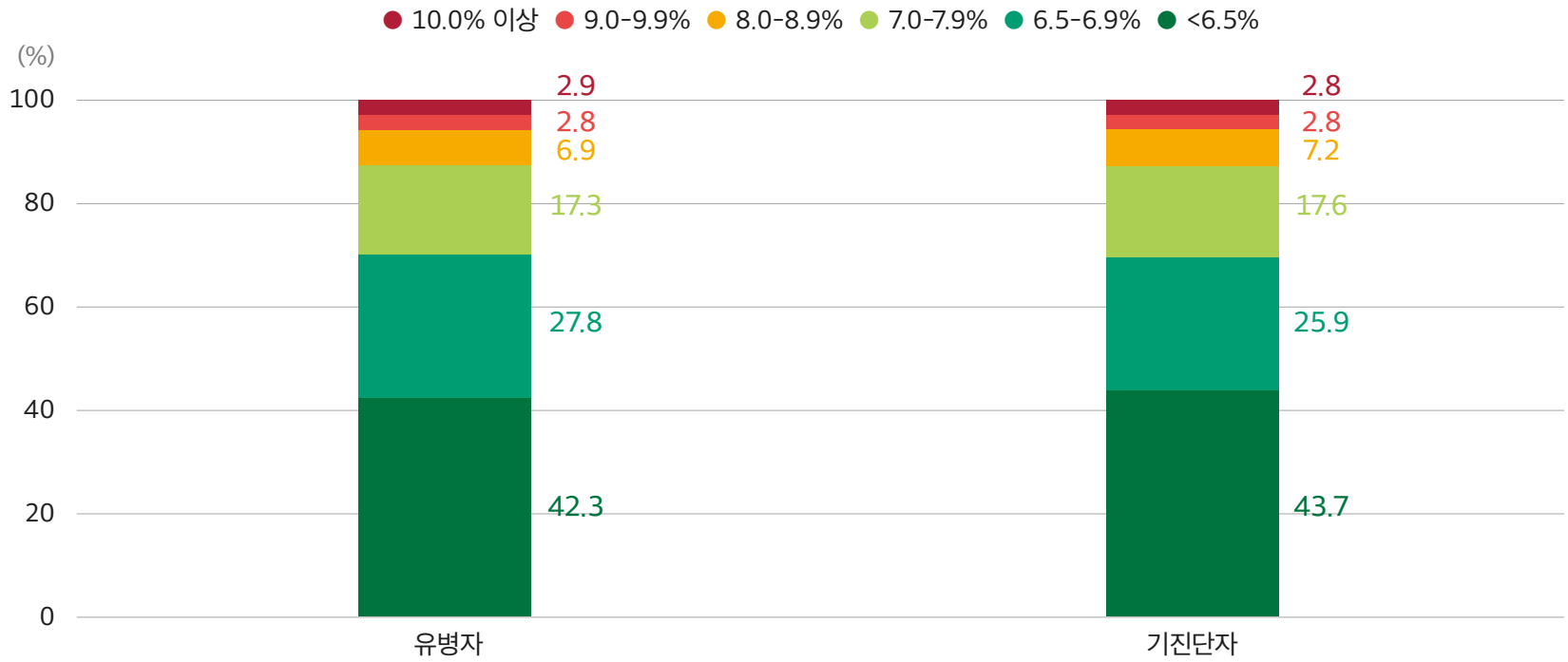
비만한 당뇨병환자의 혈당조절상태

비만한 당뇨병 환자는 비만하지 않은 경우보다 당화혈색소 6.5% 미만 조절률이 낮았고(39.9% vs 42.3%), 7.0% 미만 조절률도 더 낮음(63.8% vs 70.1%).
반면, 8.0% 이상은 16.1%로 비만하지 않은 경우(12.6%)보다 높은 비율을 보임.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상

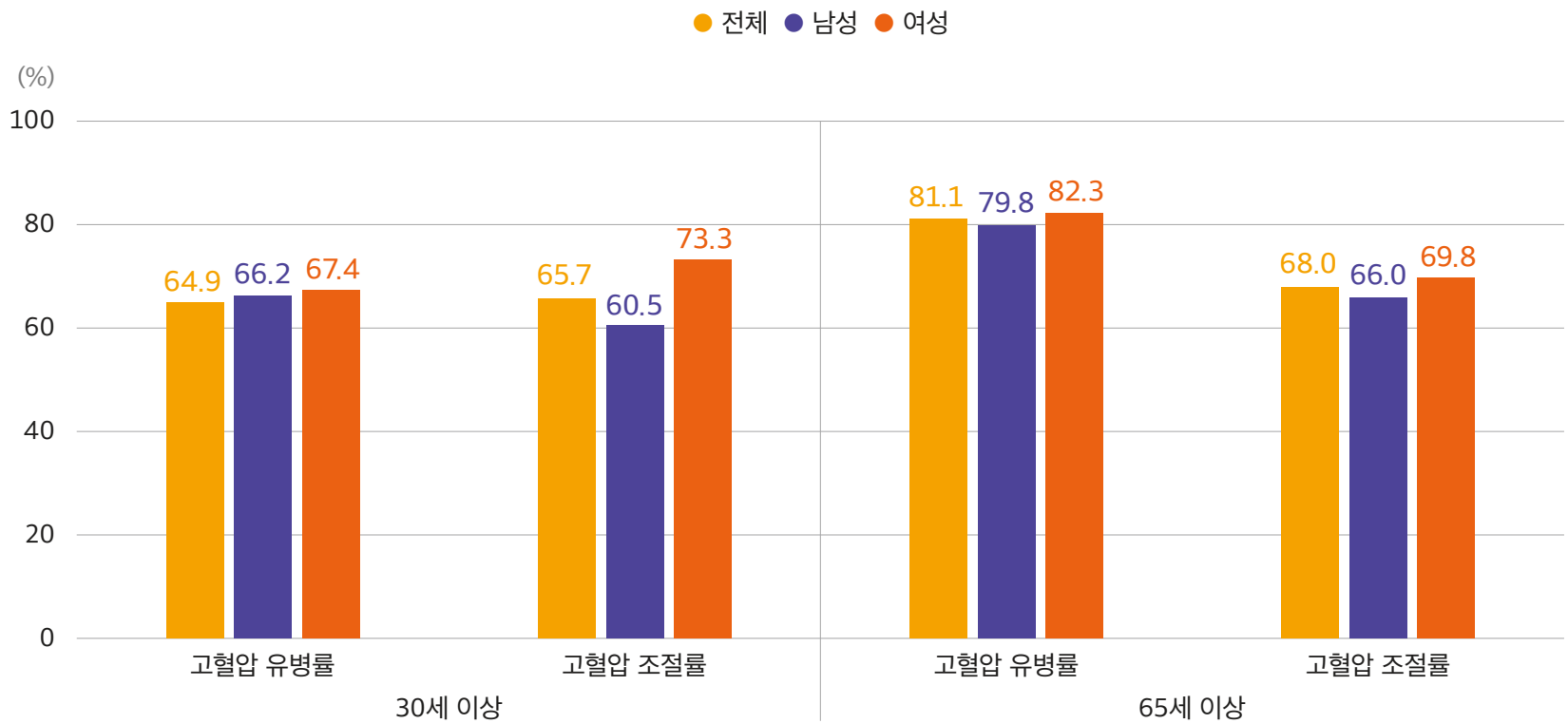
비비만 당뇨병환자의 혈당조절상태



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

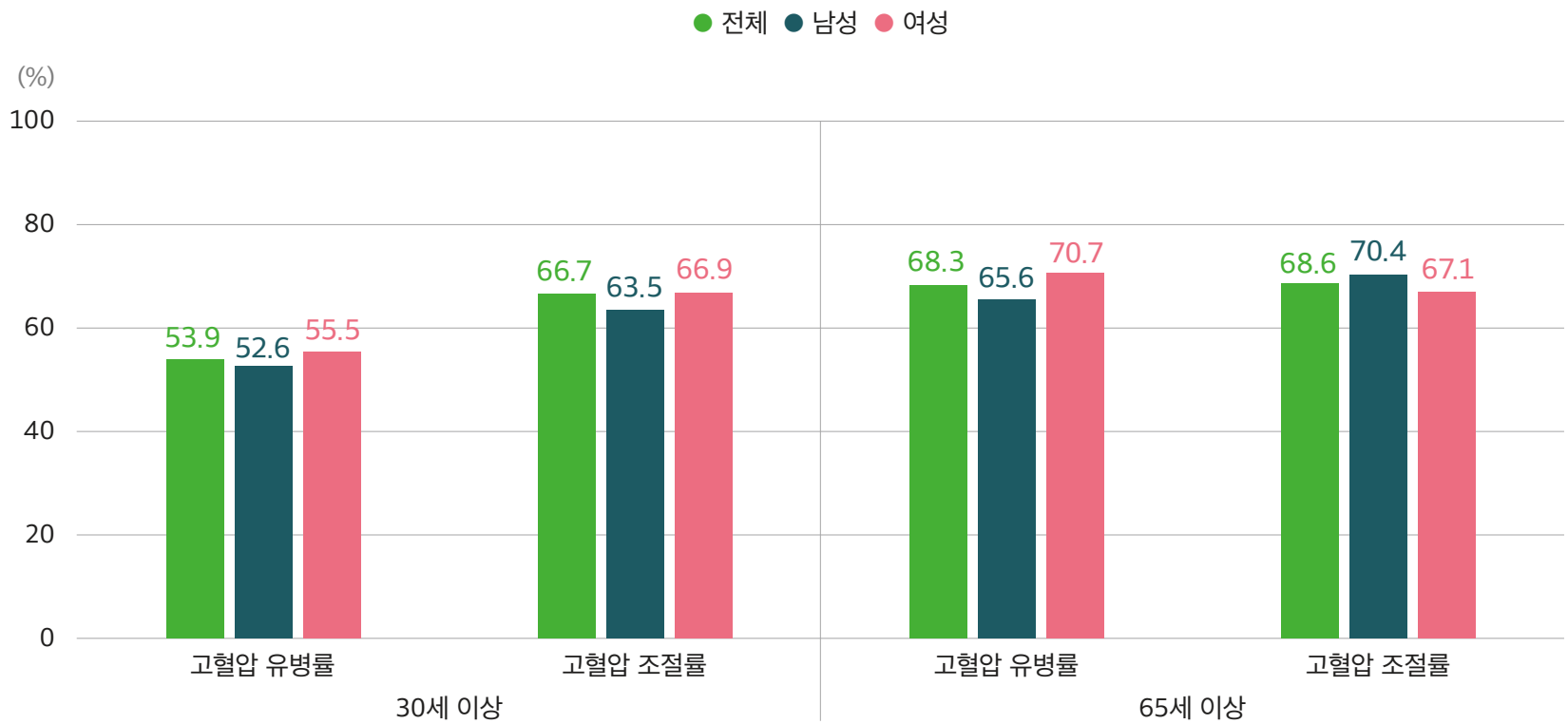
비만한 당뇨병환자의 고혈압

비만한 당뇨병 환자에서 고혈압 유병률은 비비만군보다 높았으며, 이러한 차이는 남녀 모두에서 확인됨.
비만한 당뇨병 환자의 10명 중 6명은 고혈압을 동반하였고, 65세 이상에서는 10명 중 8명으로 증가함.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
고혈압 유병률: 수축기혈압이 140 mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90 mmHg 이상 또는 고혈압약물를 복용한 분율
고혈압 조절률: 수축기혈압이 140 mmHg 미만이고 이완기혈압이 85 mmHg 미만인 분율

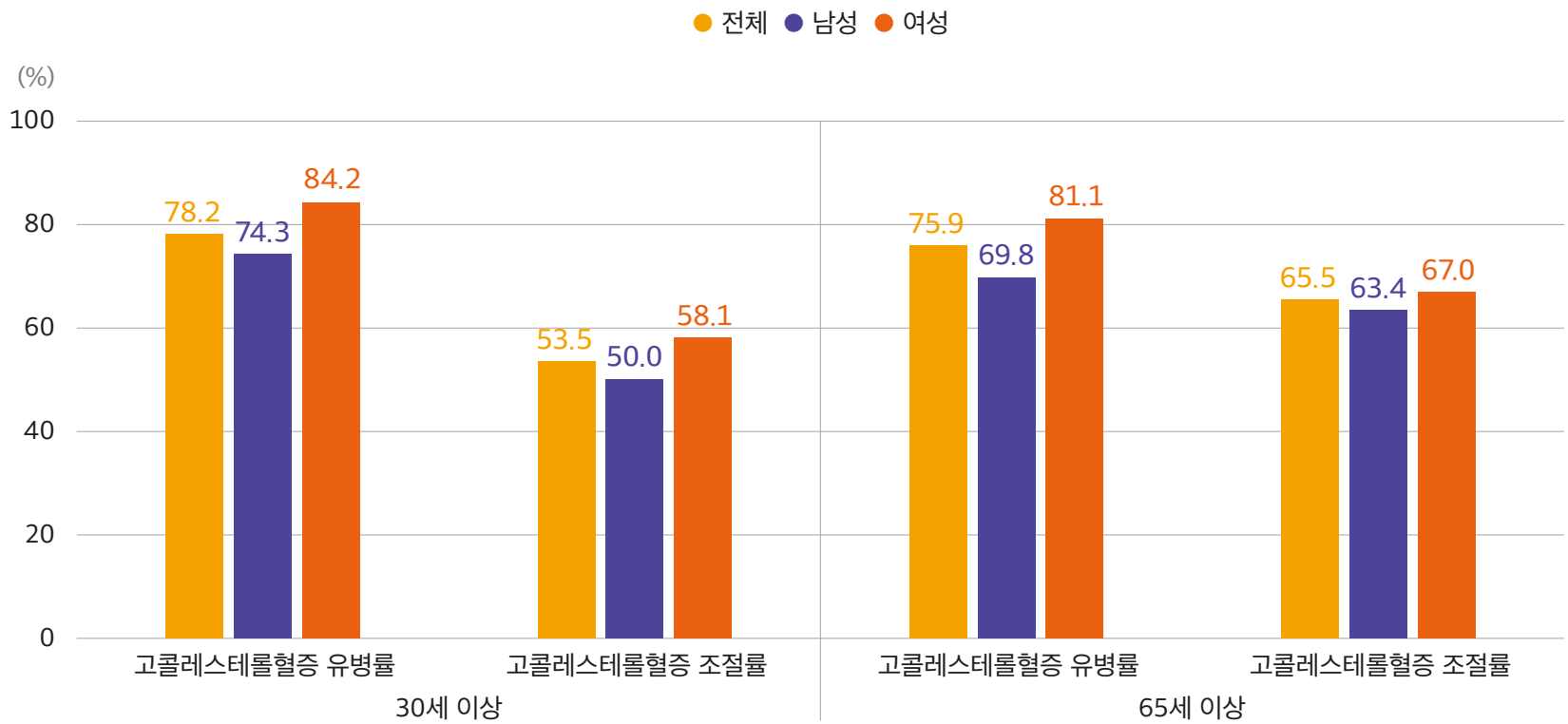
비비만 당뇨병환자의 고혈압



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만
고혈압 유병률: 수축기혈압이 140 mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90 mmHg 이상 또는 고혈압약물를 복용한 분율
고혈압 조절률: 수축기혈압이 140 mmHg 미만이고 이완기혈압이 85 mmHg 미만인 분율

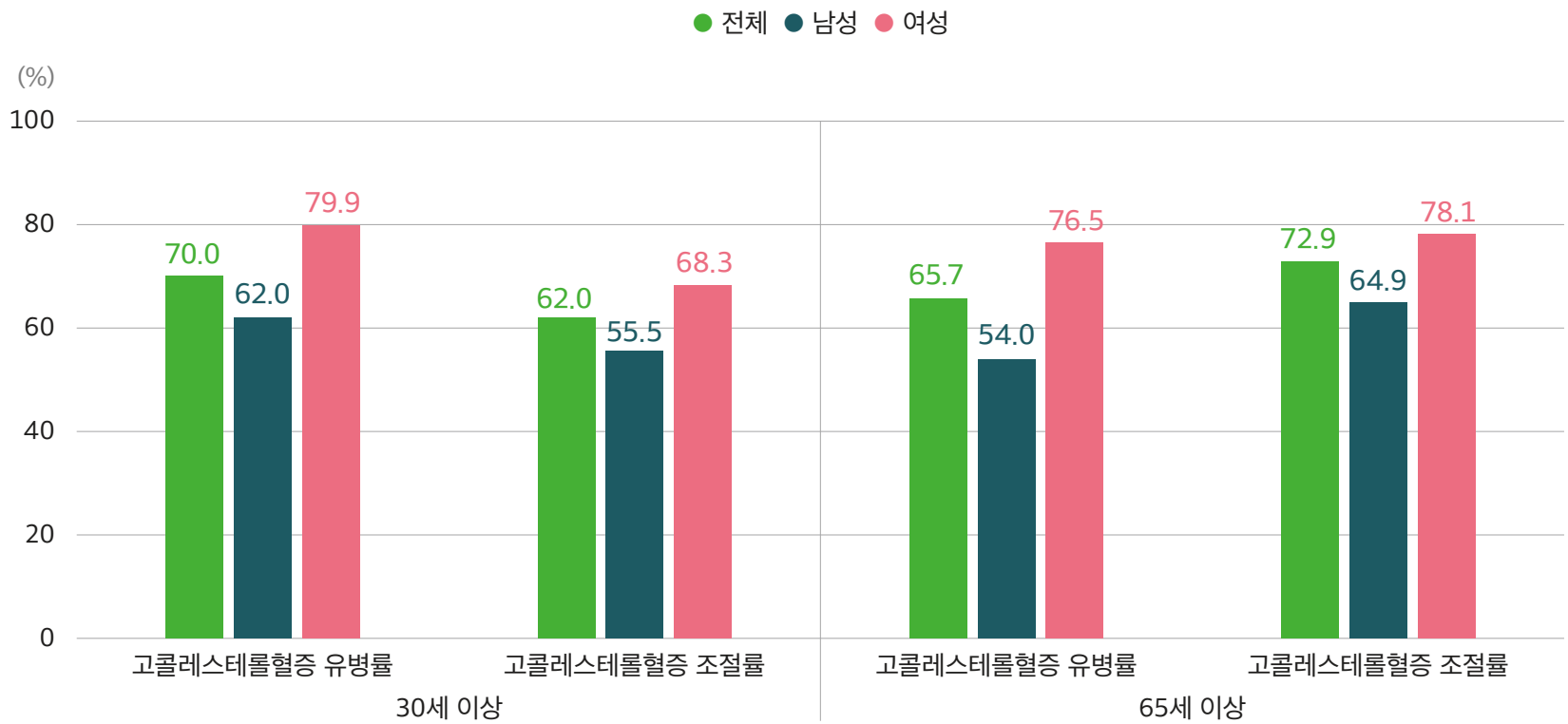
비만한 당뇨병환자의 고콜레스테롤혈증

비만한 당뇨병 환자의 고콜레스테롤혈증 유병률은 78.2%로 비비만군보다 높았으나 조절률은 53.5%로 더 낮았음.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
고콜레스테롤혈증 유병률: 혈중 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율(%)
고콜레스테롤혈증 조절률: 혈중 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 미만인 분율(%)

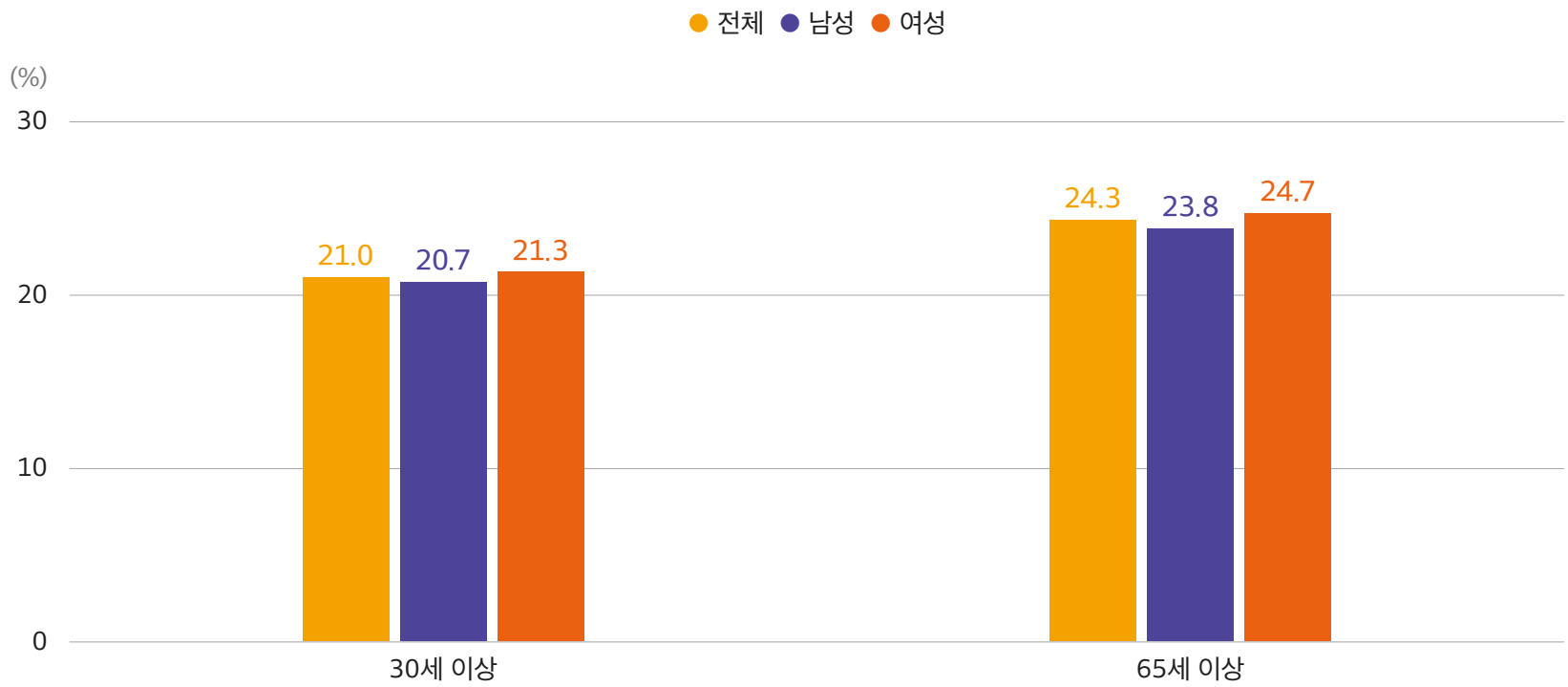
비비만 당뇨병환자의 고콜레스테롤혈증



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만
고콜레스테롤혈증 유병률: 혈중 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율(%)
고콜레스테롤혈증 조절률: 혈중 LDL 콜레스테롤이 100 mg/dL 미만인 분율(%)

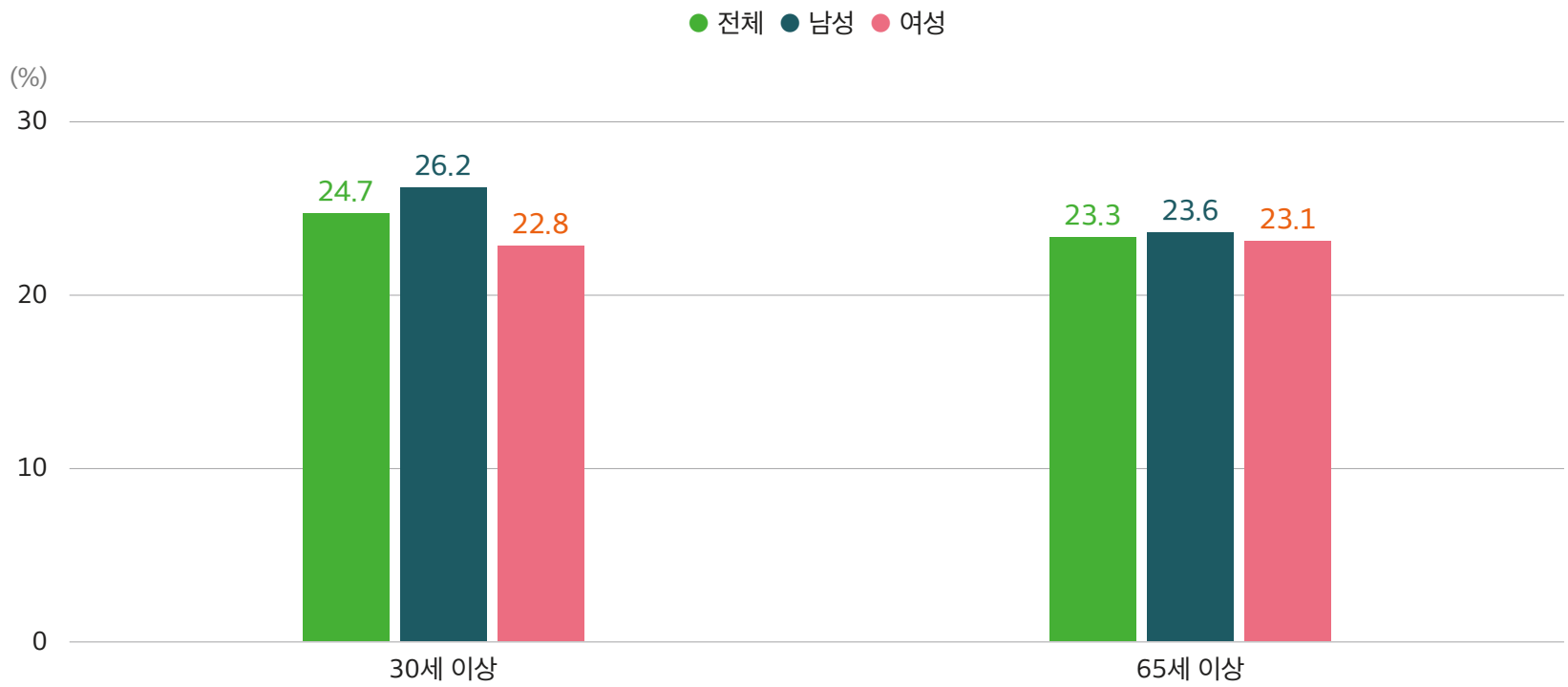
비만한 당뇨병환자의 통합관리

혈당, 혈압, LDL 콜레스테롤이 모두 목표치 내로 조절된 비율은 비만 당뇨병군이 21.0%로 비비만 당뇨병군(24.7%)보다 낮았음. 65세 이상에서는 두 군 간 큰 차이가 없었음.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
통합관리: 당화혈색소 6.5% 미만, 혈압 140/85 mmHg 미만, LDL 콜레스테롤 100 mg/dL 미만의 세 가지 목표에 모두 도달한 경우

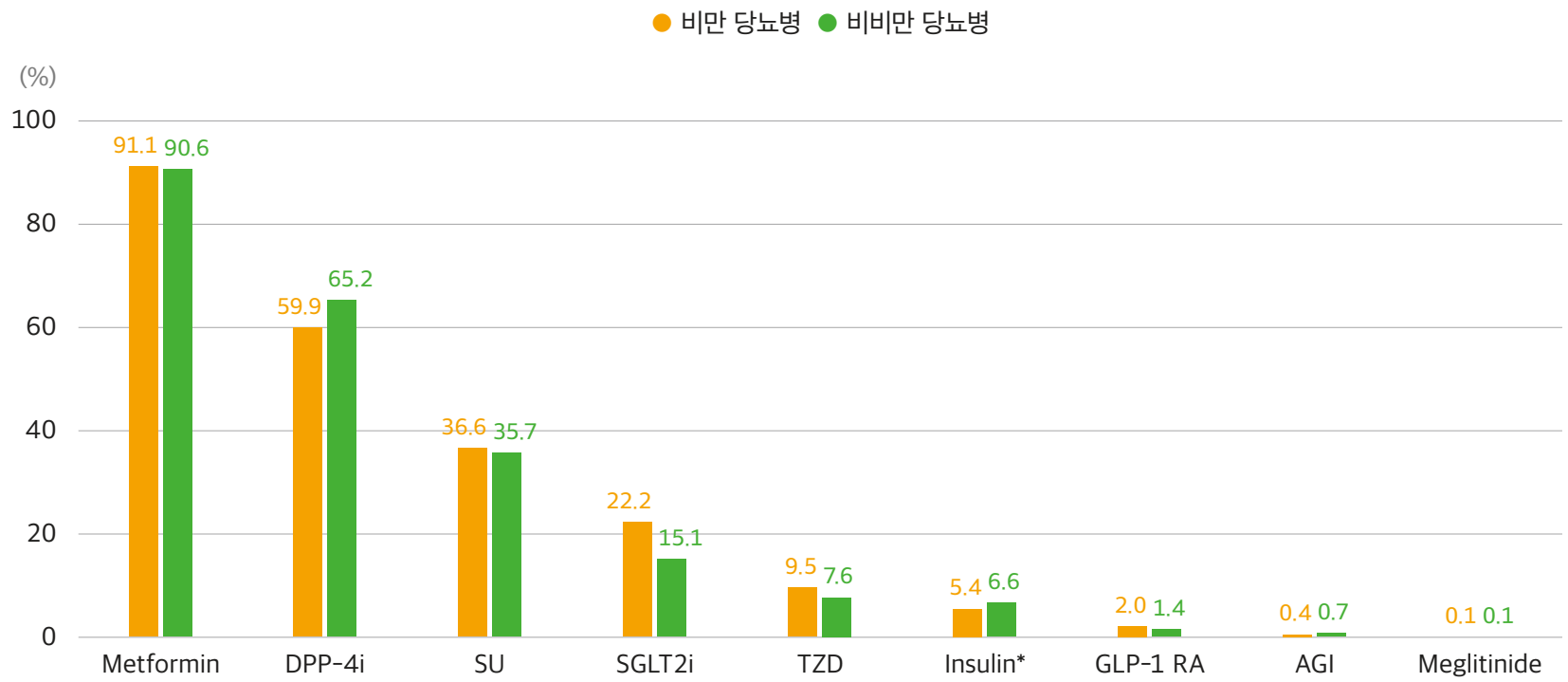
비비만 당뇨병환자의 통합관리



비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만
통합관리: 당화혈색소 6.5% 미만, 혈압 140/85 mmHg 미만, LDL 콜레스테롤 100 mg/dL 미만의 세 가지 목표에 모두 도달한 경우

비만과 비비만 당뇨병, 당뇨병약물 처방 현황

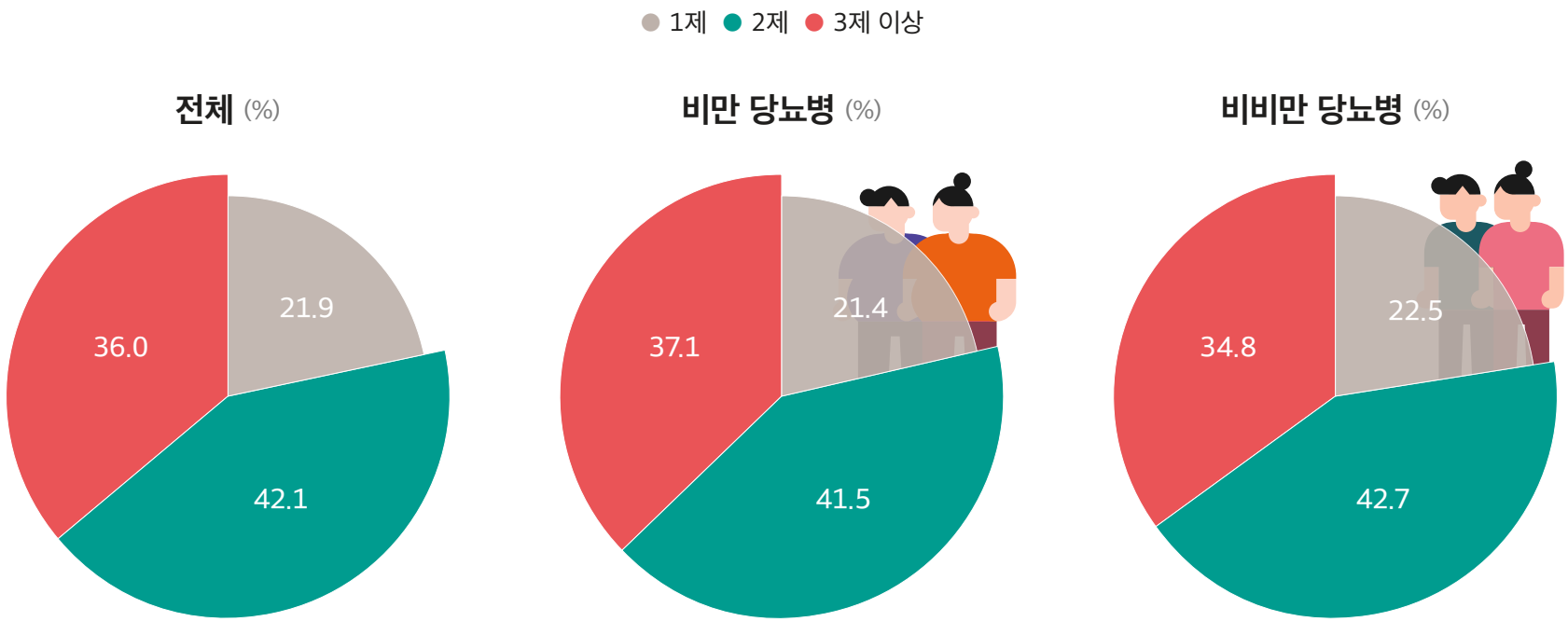
비만과 비비만 당뇨병 환자 모두에서 메트포민이 가장 많이 처방되었으며, DPP-4 억제제가 뒤를 이음.
비만 당뇨병 환자에서 SGLT2 억제제가 더 많이 처방됨.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상 / 비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만
SU: sulfonylurea, TZD: thiazolidinedione, AGI: alpha-glucosidase inhibitor, DPP-4i: dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, SGLT2i: sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor, GLP-1 RA: glucagon-like peptide-1 receptor agonist(Dulaglutide)
*Insulin: 1년에 3회 이상 처방된 경우

비만과 비비만 당뇨병, 당뇨병약물 처방 현황

비만과 비비만 당뇨병 환자 모두 약 80%에서 병용요법이 처방됨.



비만: 체질량지수 25 kg/m^2 이상
비비만: 체질량지수 25 kg/m^2 미만

비만대사수술 현황과 비만 당뇨병의 예후

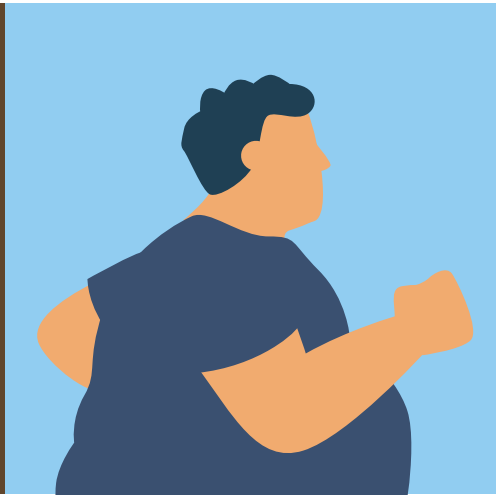
OBESITY

IV

비만대사수술 건수

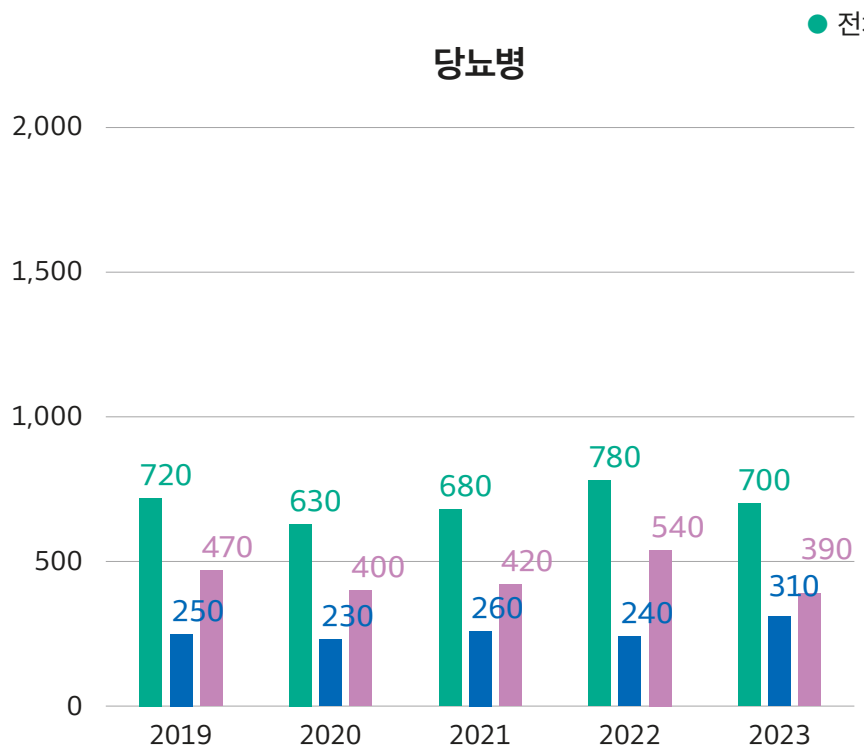
비만대사수술 방법 현황

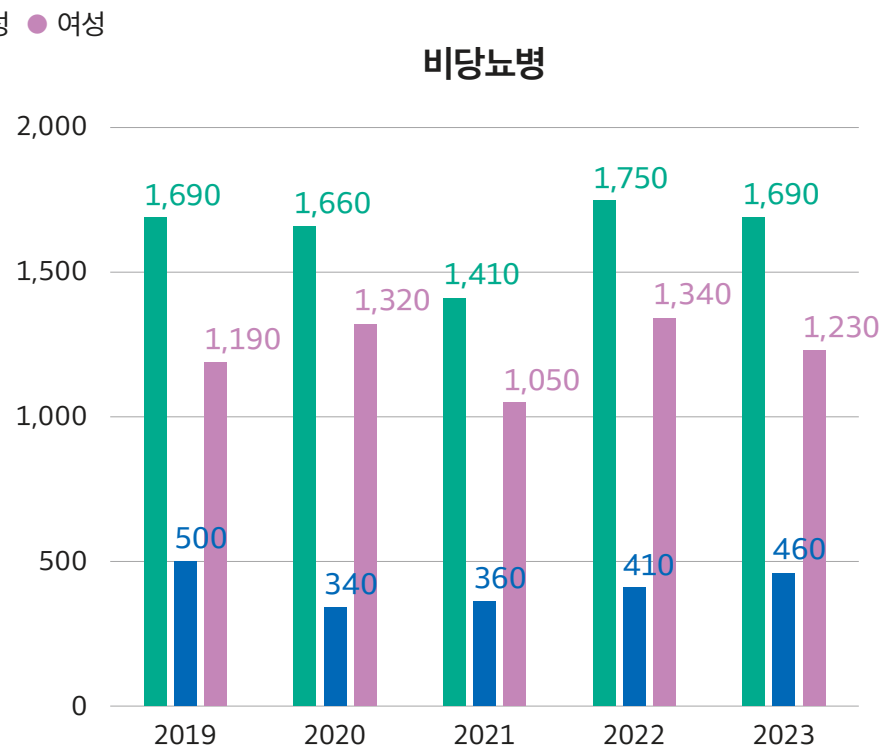
당뇨병 환자의 비만 단계별 암 발생 위험



비만대사수술 건수 변화

당뇨병 환자에서 비만대사수술 건수는 당뇨병이 없는 인구보다 적음.
여성에서 현저히 많음. 남성에서는 소폭 증가, 여성에서는 감소 경향을 보임.

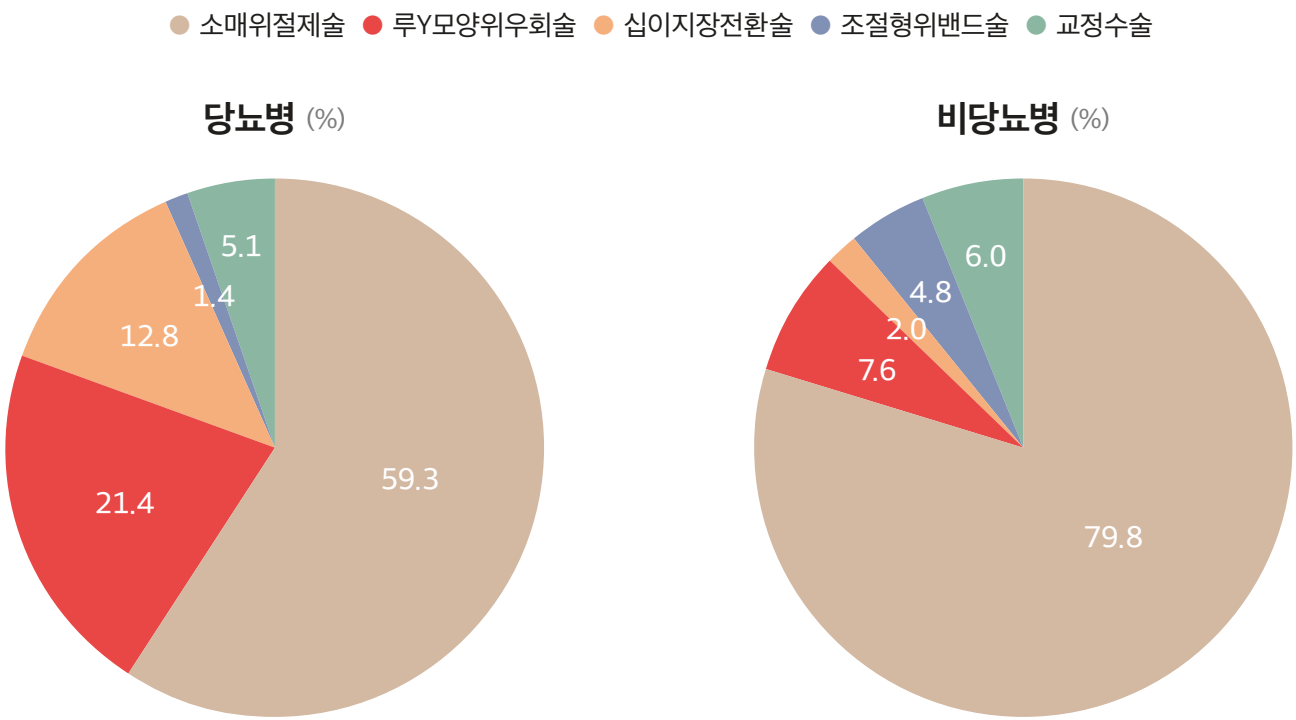




자료원: 2022년 국민건강보험공단 맞춤형 DB (10% sampling)를 활용한 추정치

비만대사수술 방법 현황

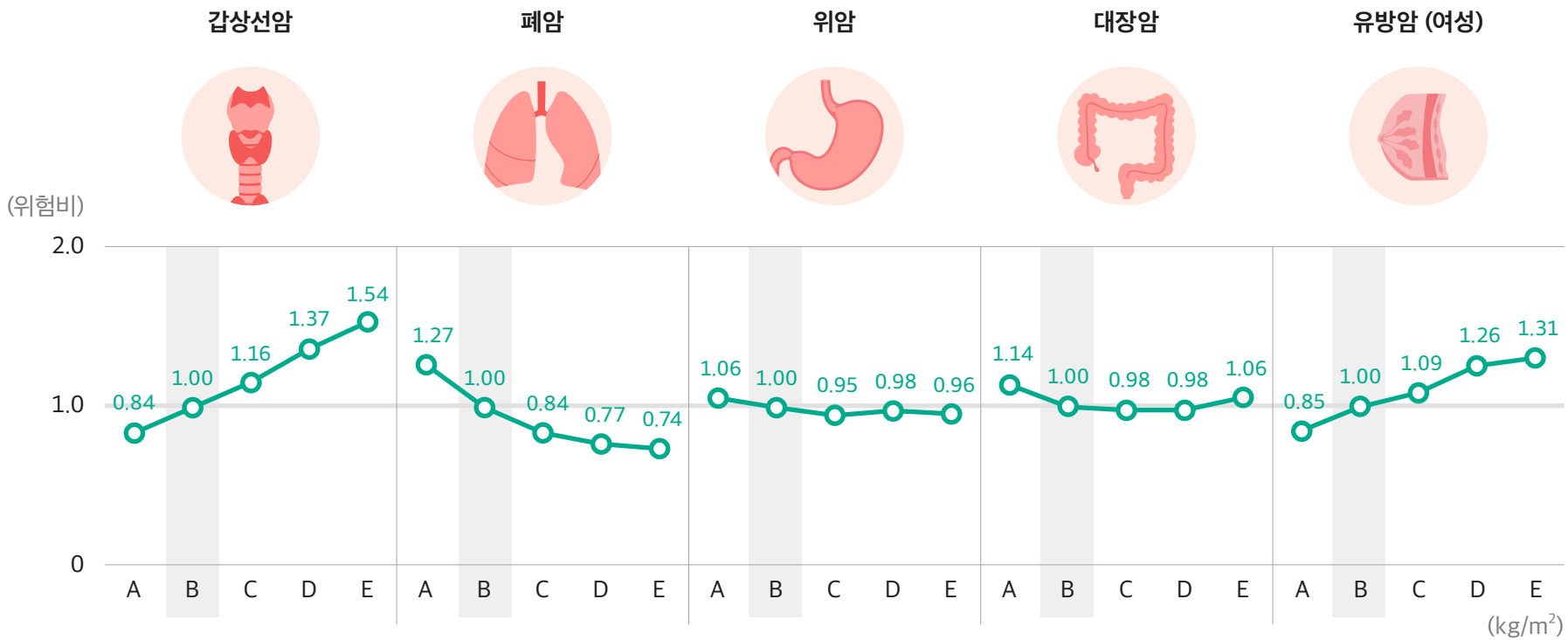
당뇨병과 비당뇨병 환자 모두에서 소매위절제술이 가장 많이 시행되었으며,
당뇨병 환자에서는 비당뇨병 환자에 비해 루Y형 위우회술과 십이지장 전환술이 더 많이 시행됨.

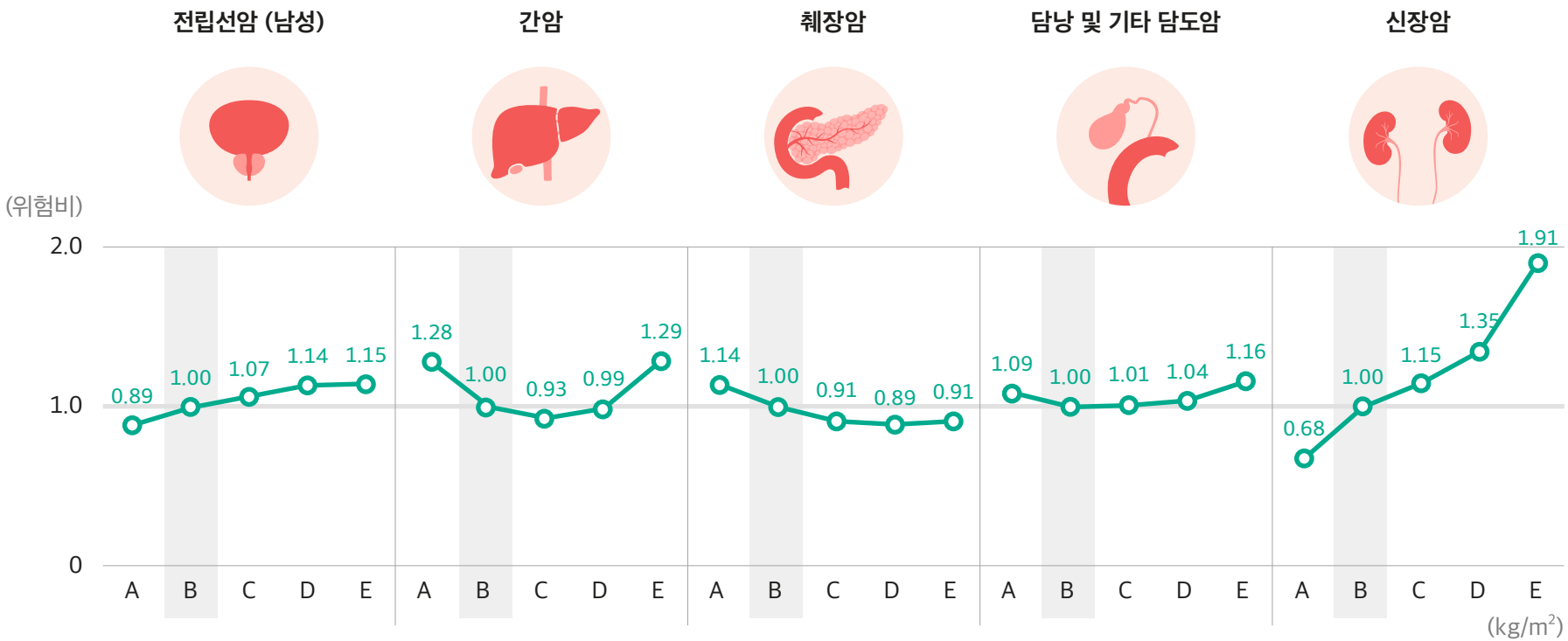


당뇨병 환자의 비만 단계별 암 발생 위험

갑상선암, 유방암, 전립선암, 신장암 발생 위험은 저체중에서 낮았으며, 체질량지수가 증가할수록 높아짐.
반대로 폐암, 위암, 췌장암은 저체중에서 발생 위험이 높고 체질량지수가 증가할수록 낮아짐.

A: <18.5
B: 18.5-22.9 (정상)
C: 23-24.9
D: 25-29.9
E: ≥30
(kg/m^2)




전립선암 (남성)
간암
췌장암
담낭 및 기타 담도암
신장암
(위험비)
2.0
1.0
0
0.89
1.00
1.07
1.14
1.15
1.28
1.00
0.93
0.99
1.29
1.14
1.00
0.91
0.89
0.91
1.09
1.00
1.01
1.04
1.16
0.68
1.00
1.15
1.35
1.91
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
(kg/m²)

PART 2
당뇨병과 임신

DIABETES FACT SHEET
IN KOREA 2025

자료원 및 분석방법 (국민건강보험공단)

자료원	국민건강보험공단에서 제공하는 2002년부터 2023년까지의 자료를 이용함.	
	청구자료	2013-2023년 분만 코드가 청구된 산모를 대상으로 함.
	검진자료	임신 이전 2년 이내에 국민건강보험공단에서 시행하는 일반건강검진을 받은 산모를 대상으로 함.
임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 정의	임신 기간	출산일로부터 280일 전부터 출산일까지의 기간
	임신당뇨병	임신전당뇨병을 제외하고, 출산일로부터 2개월 전부터 출산일까지의 기간에 ICD-10 코드 O24.4, O24.9 혹은 임신 중 인슐린이 청구된 경우
	임신전당뇨병	출산 전 ICD-10 코드 E10-14와 함께 당뇨병약물이 청구된 경우
	임신중당뇨병	임신당뇨병과 임신전당뇨병을 모두 포함하는 개념
동반질환 및 합병증의 정의	고혈압	ICD-10 코드 I10-13, I15와 함께 고혈압약물이 청구된 경우
	이상지질혈증	ICD-10 코드 E78과 함께 지질강하제가 청구된 경우
	2형당뇨병	ICD-10 코드 E11-14와 함께 당뇨병약물이 청구된 경우
	심근경색	ICD-10 코드 I21, I22로 입원한 경우
	허혈뇌졸중	ICD-10 코드 I63, I64로 입원하였으며, 뇌 CT 또는 MRI가 함께 청구된 경우

2형당뇨병, 심근경색, 허혈뇌졸중 발생은 2003-2013년 사이 출산한 산모를 대상으로 2023년 12월 31일까지 추적관찰하여 분석함.
각 위험비는 나이를 보정한 콕스 비례위험모형을 이용하여 제시함.
ICD-10: International Classification of Diseases, 10th Revision

임신중당뇨병 유병률 (최근 10년간 변화)

PREGNANCY

I

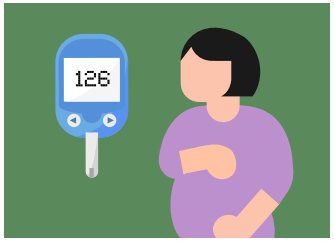
임신당뇨병 및 임신전당뇨병 유병률

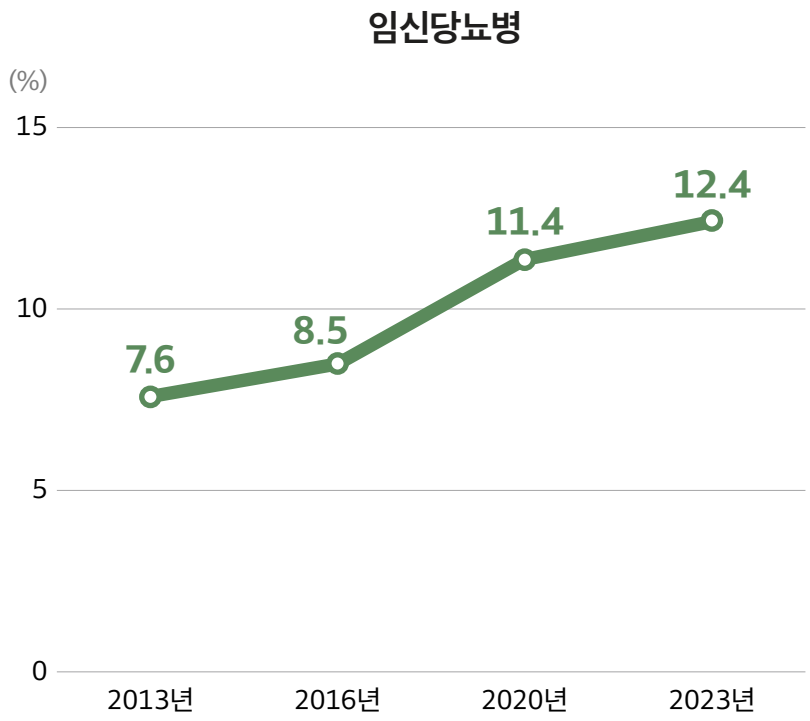
임신당뇨병 유병률

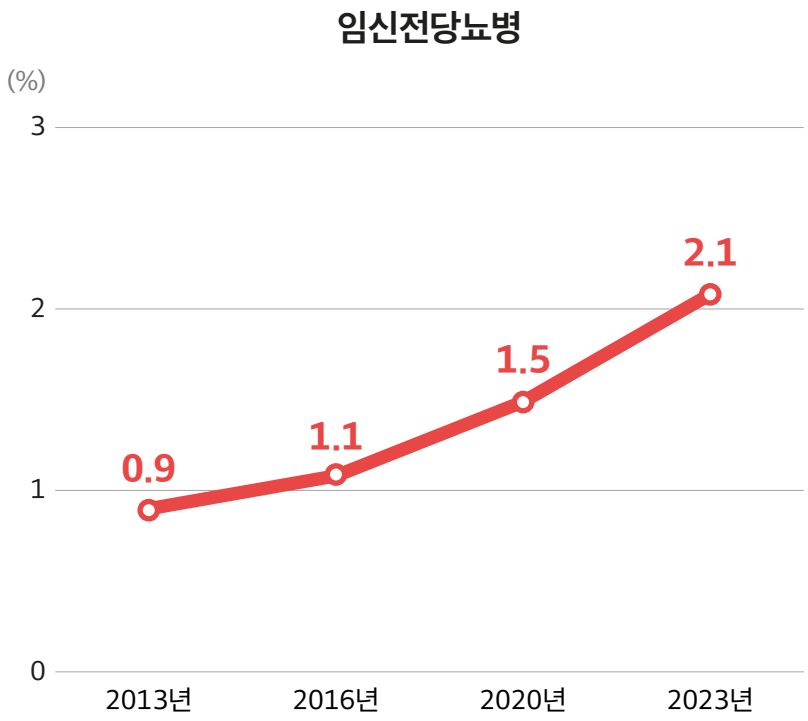
임신전당뇨병 유병률

임신당뇨병 및 임신전당뇨병 유병률

임신당뇨병과 임신전당뇨병의 유병률은 10년 전에 비해 증가함.
2023년 전체 임신의 10% 이상에서 임신당뇨병이 동반되었으며, 임신전당뇨병의 경우 2%를 초과함.

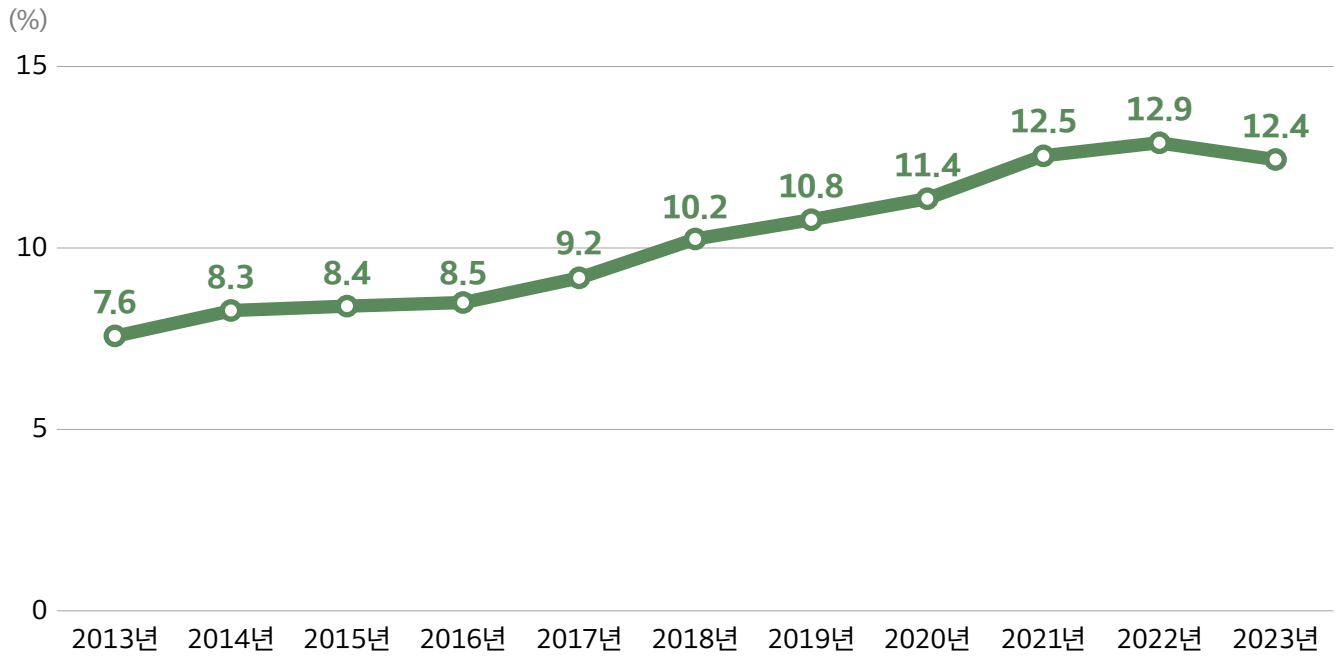






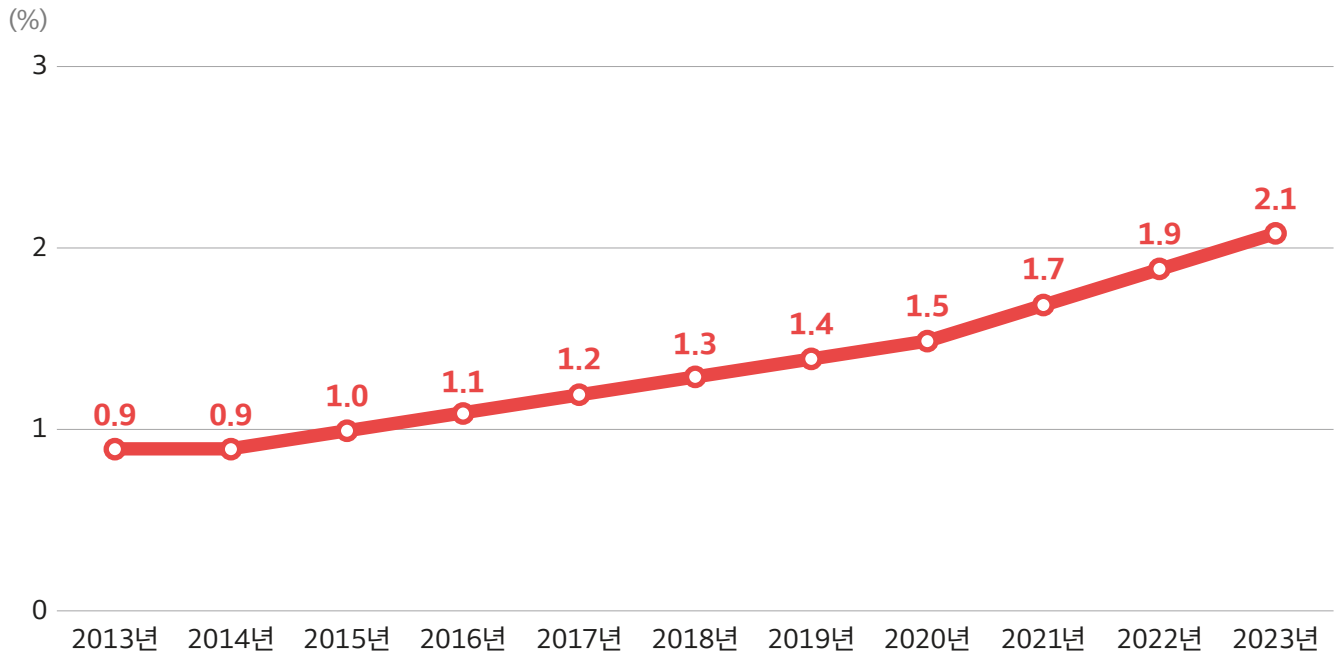
임신당뇨병 유병률

임신당뇨병의 유병률은 2013년 7.6%에서 2023년 12.4%로 증가함.
2018년 이후로 전체 임신의 10% 이상에서 임신당뇨병을 동반함.



임신전당뇨병 유병률

임신전당뇨병의 유병률은 2013년 0.9%에서 지속적으로 증가하여 2023년에는 전체 임신의 2%를 초과함.



산모의 임상적 특성 (최근 10년간 변화)

PREGNANCY

II

출산연령 변화

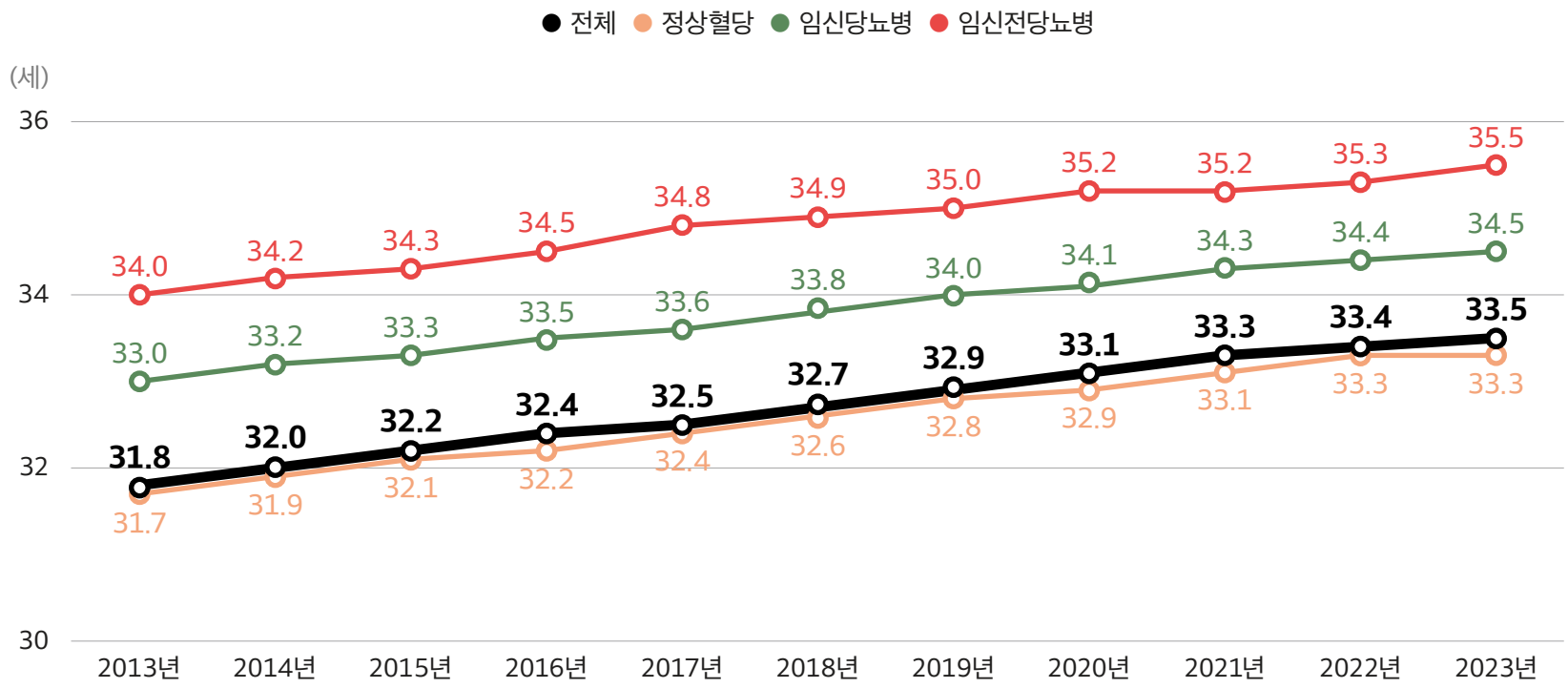
임신전 체질량지수 변화

임신전 허리둘레 변화

임신전 공복혈당 변화

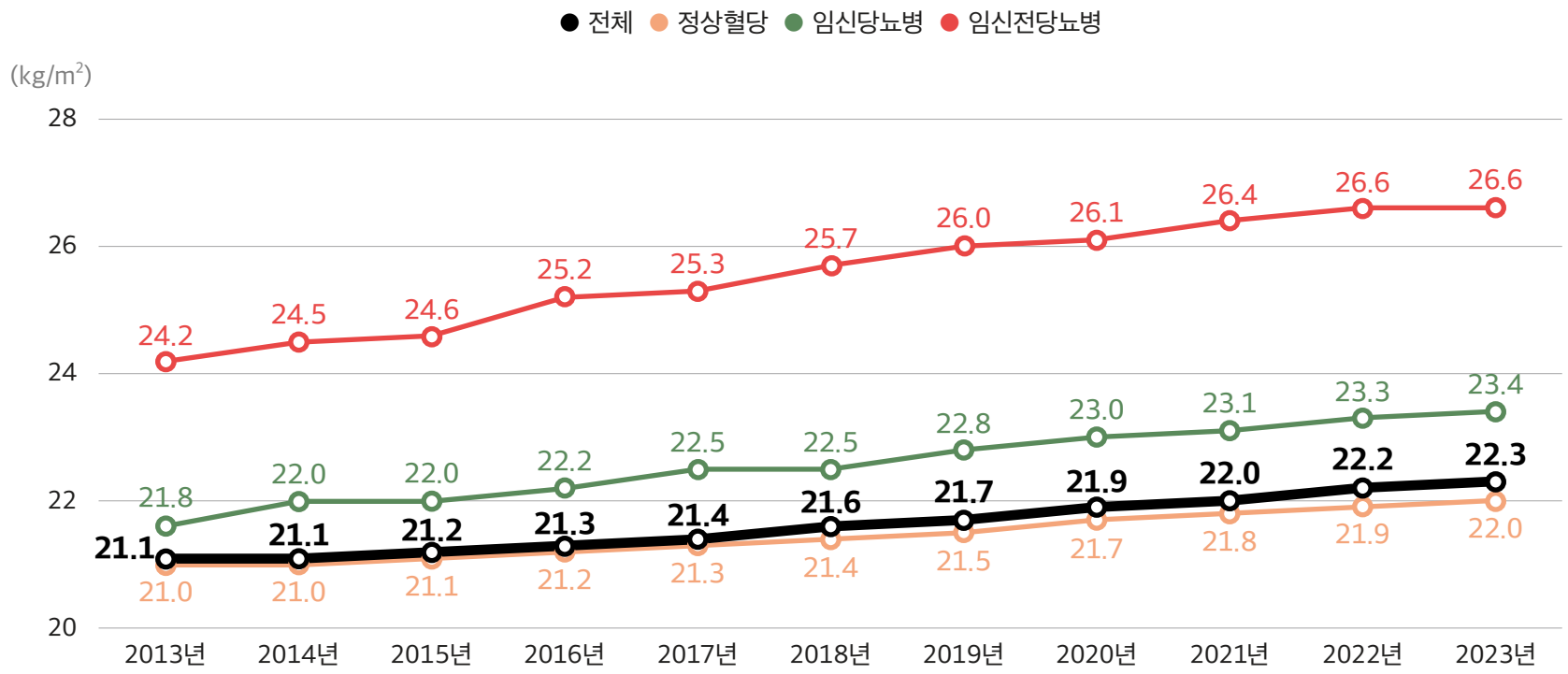
출산연령 변화

최근 10년간 전체 산모의 평균 출산연령이 31.8세에서 33.5세로 증가함.
정상혈당 산모에 비해 임신당뇨병 및 임신전당뇨병 산모에서 출산연령이 더 높음.



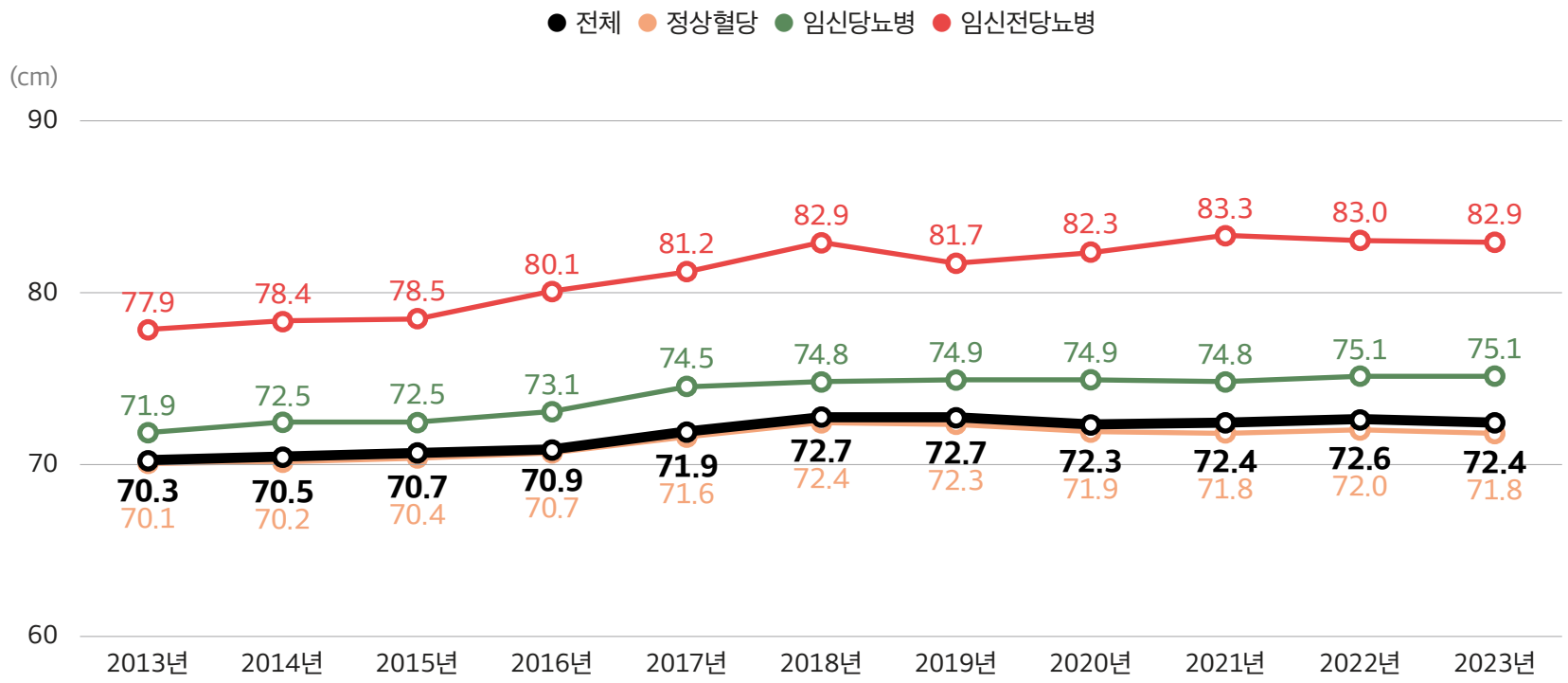
임신전 체질량지수 변화

최근 10년간 전체 산모의 임신전 체질량지수가 21.1 kg/m^{2}에서 22.3 kg/m^{2}로 증가함.
정상혈당 산모에 비해 임신당뇨병 및 임신전당뇨병 산모에서 비만도가 더 높음.



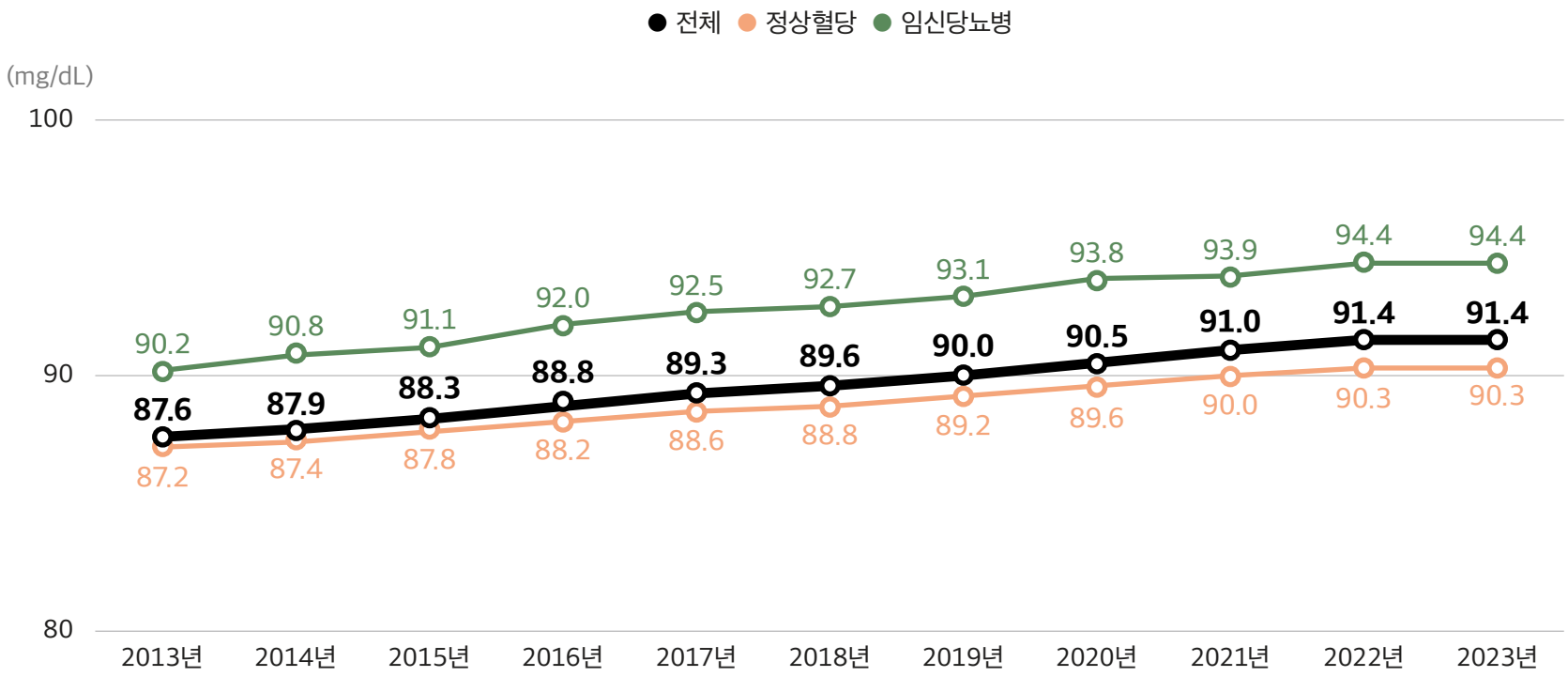
임신전 허리둘레 변화

최근 10년간 전체 산모의 임신전 허리둘레가 70.3 cm에서 72.4 cm로 증가함.
정상혈당 산모에 비해 임신당뇨병 및 임신전당뇨병 산모에서 임신전 허리둘레가 더 큼.



임신전 공복혈당 변화

최근 10년간 전체 산모의 임신전 공복혈당이 87.6 mg/dL에서 91.4 mg/dL로 증가함.
정상혈당 산모에 비해 임신당뇨병 산모에서 임신전 공복혈당이 높음.



임신중당뇨병의 혈당관리 방법

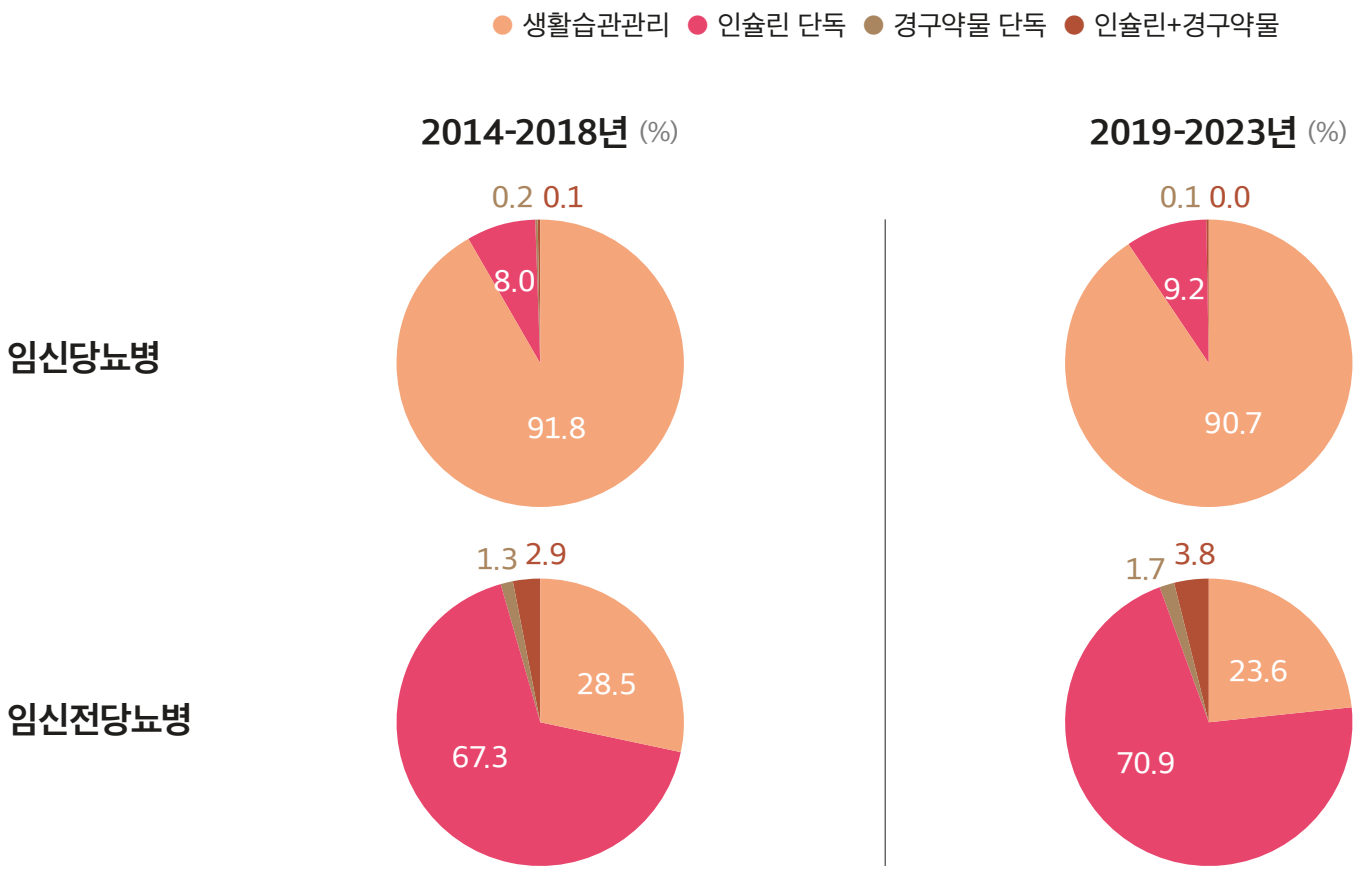
임신중당뇨병의 혈당관리 방법

PREGNANCY

III

임신당뇨병의 혈당관리 방법

임신당뇨병 산모의 약 90%가 생활습관관리만으로 혈당을 관리하며, 약물요법의 경우 대부분 경구약물 없이 인슐린 단독으로 혈당을 조절함.
임신전당뇨병 산모의 4명 중 1명은 생활습관관리만으로 혈당을 관리하며, 대부분 인슐린으로 혈당을 조절하지만 5% 가량은 경구약물을 사용함.



임신중당뇨병의 위험요인

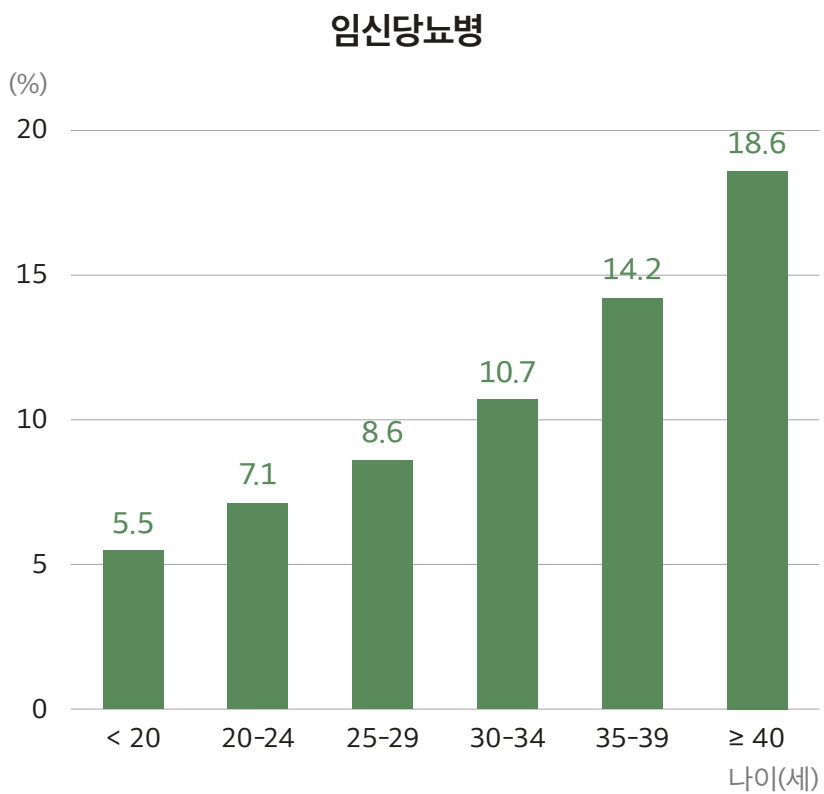
PREGNANCY

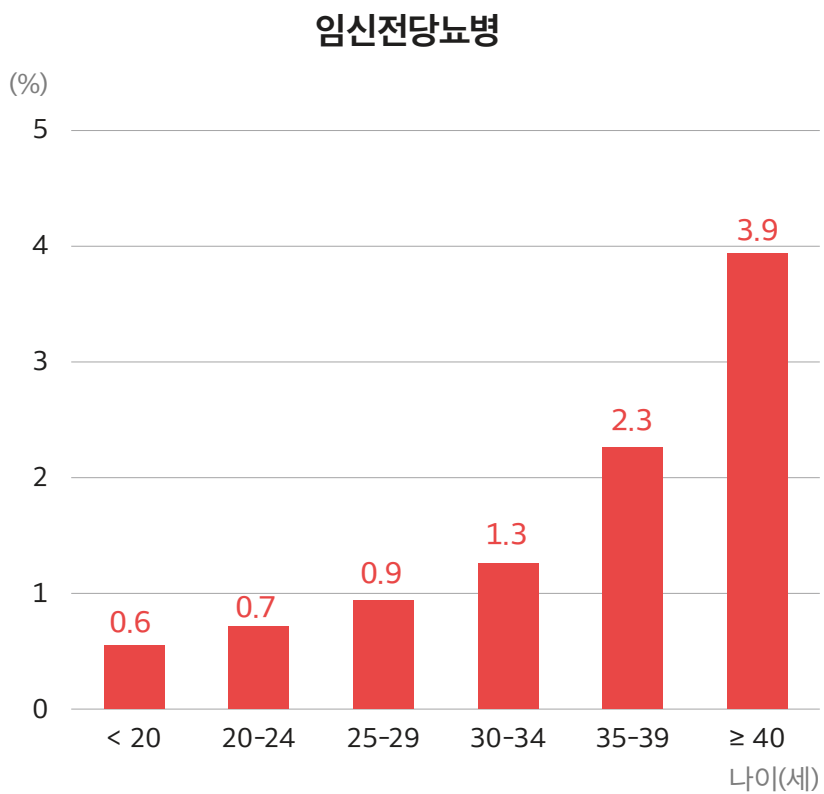
IV

연령에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
소득에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
체질량지수에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
허리둘레에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
공복혈당에 따른 임신당뇨병 유병률
임신전 고혈압에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률
임신전 이상지질혈증에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

연령에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

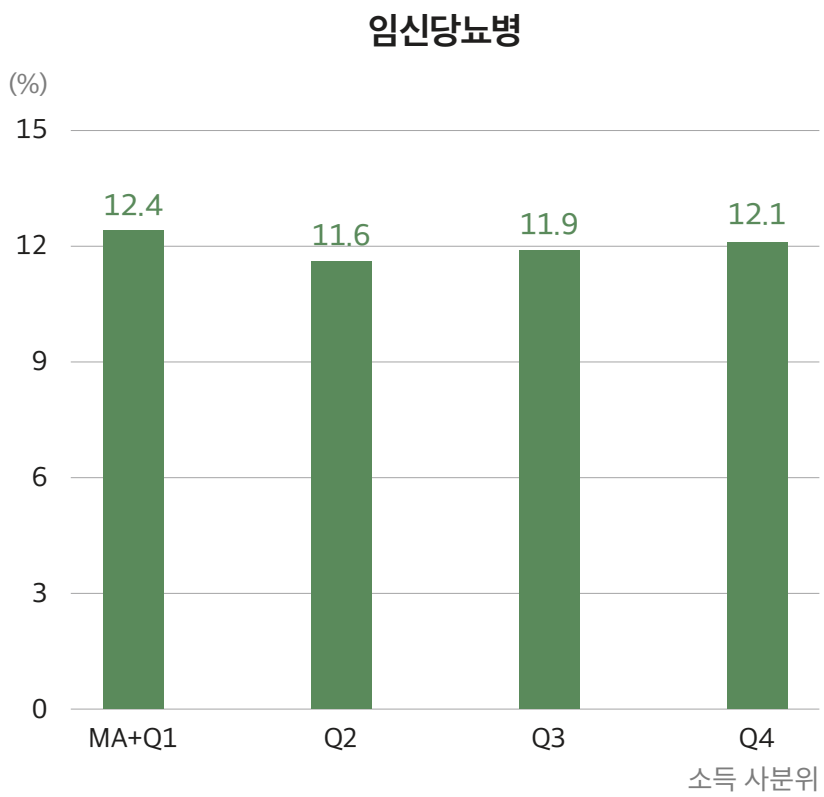
연령이 증가함에 따라 임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 유병률이 증가함.
40세 이상 산모의 약 5명 중 1명에서 임신당뇨병을 동반함.

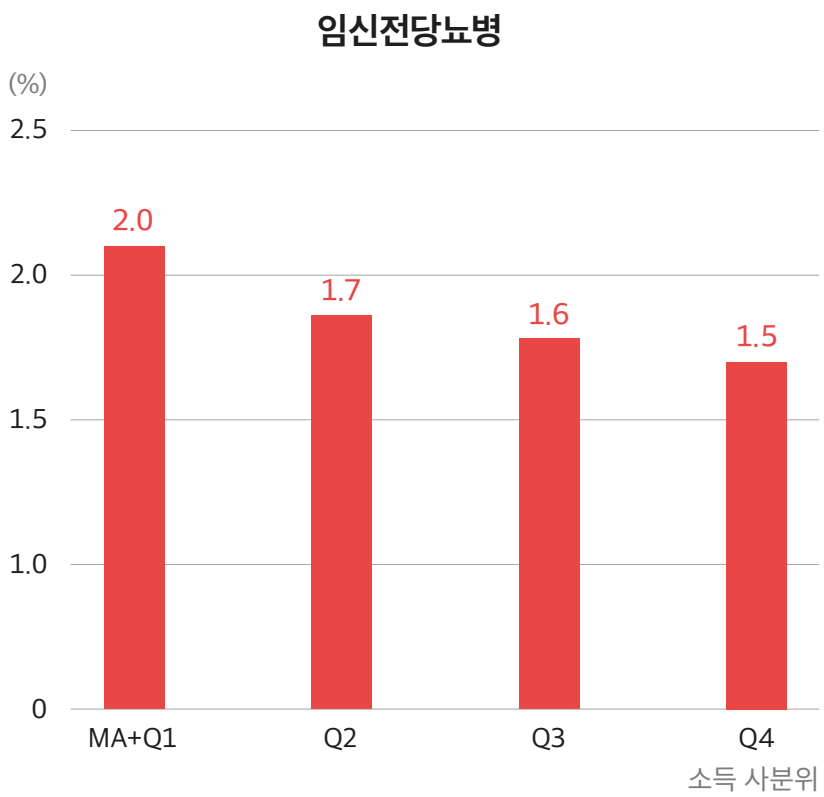




소득에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

저소득층(의료급여 및 하위 4분위)에서 임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 유병률이 가장 높음.

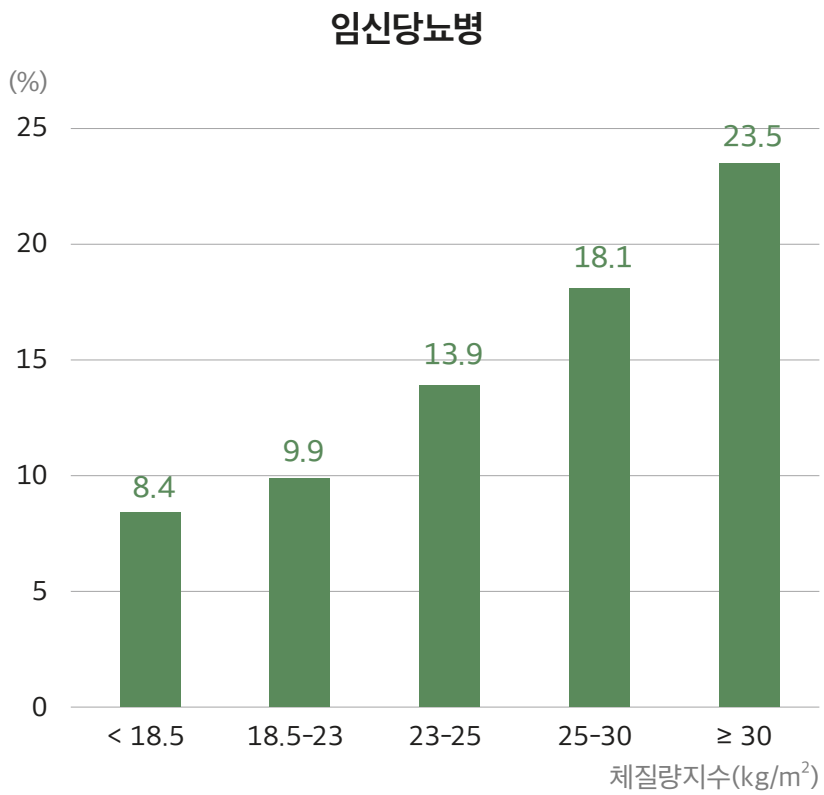


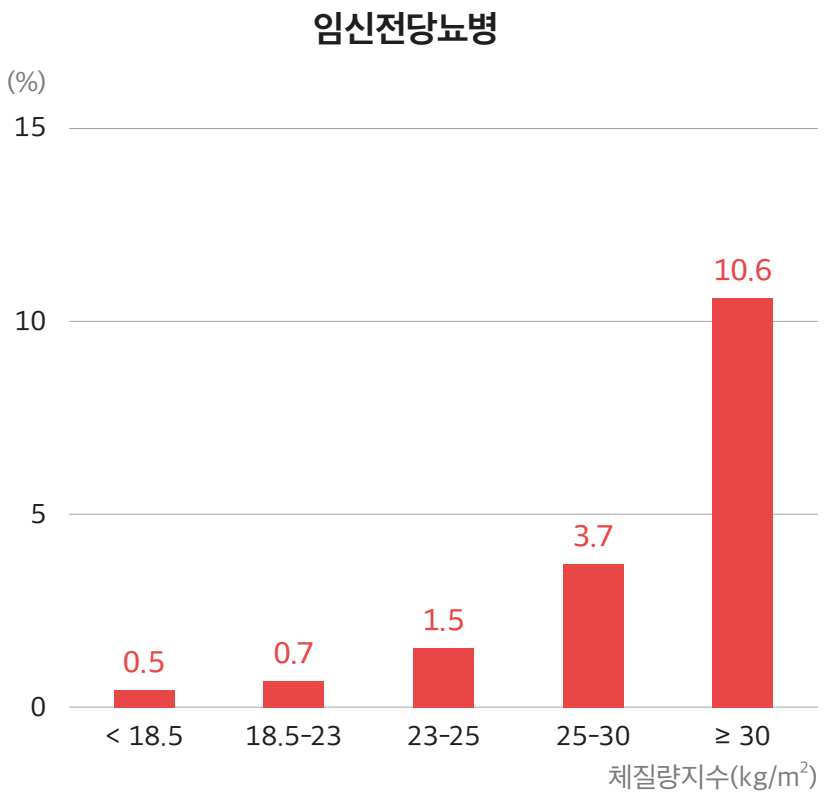


MA, 의료급여 (medical aid). Q, 소득 사분위.

체질량지수에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

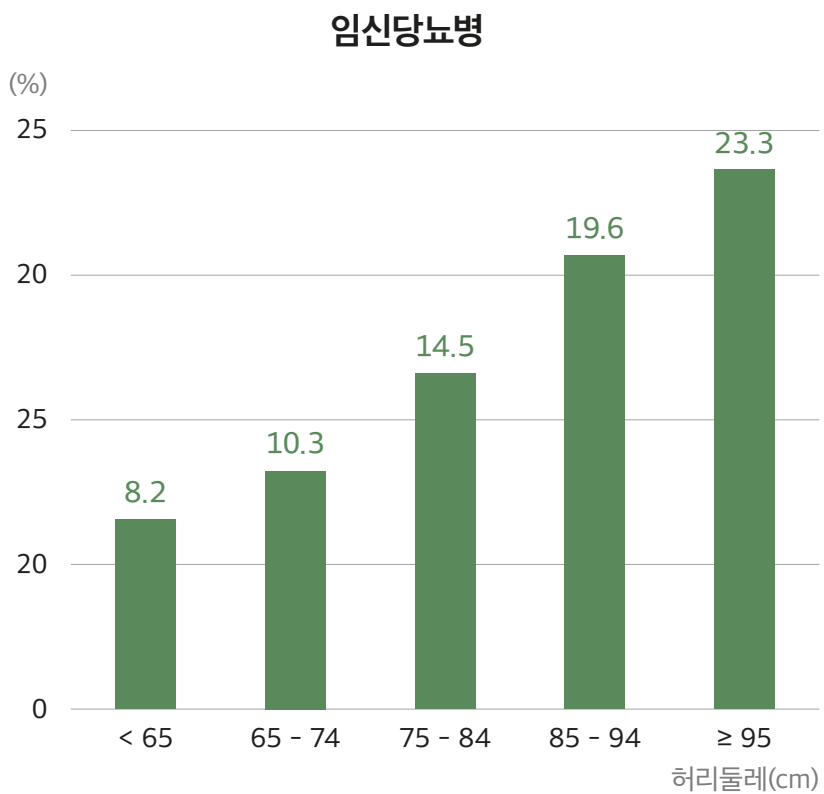
체질량지수가 증가함에 따라 임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 유병률이 증가함.
비만한 산모의 5명 중 1명에서 임신당뇨병을 동반함.

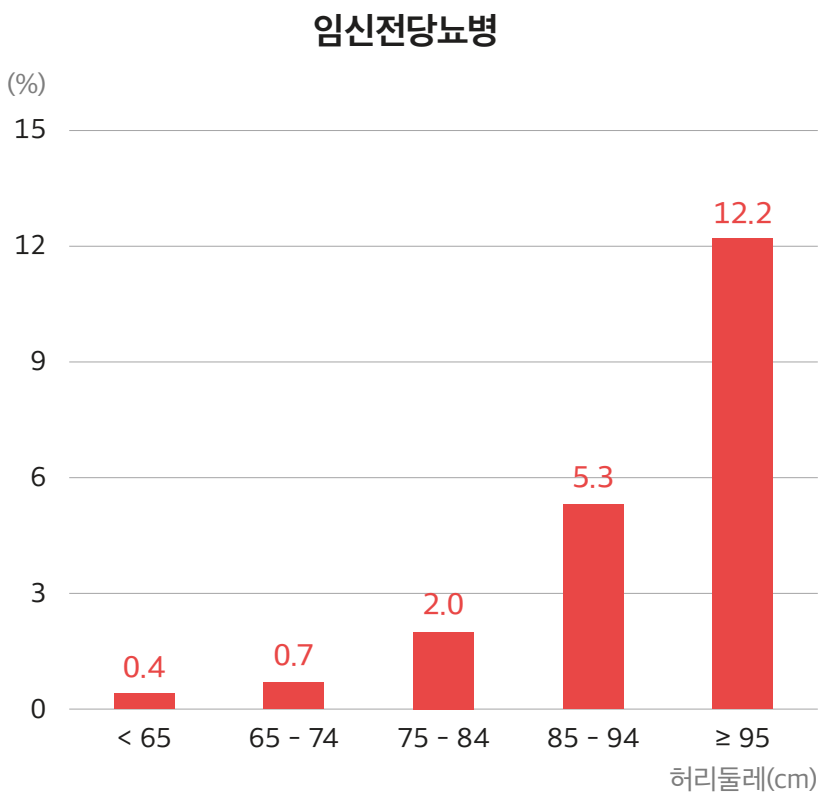




허리둘레에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

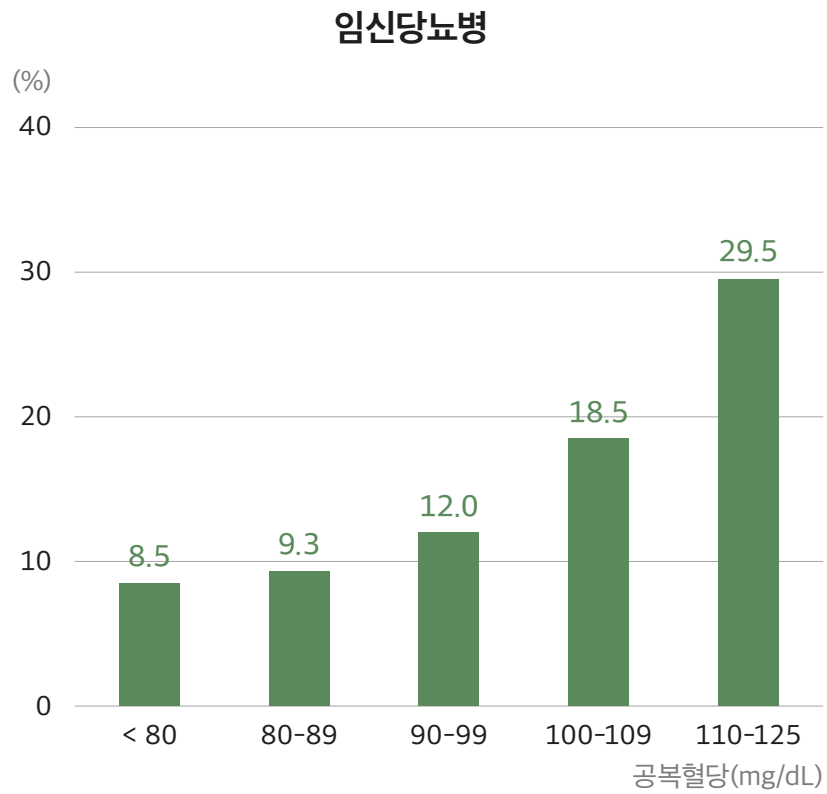
허리둘레가 증가함에 따라 임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 유병률이 증가함.
복부비만을 동반한 5명 중 1명에서 임신당뇨병을 동반함.





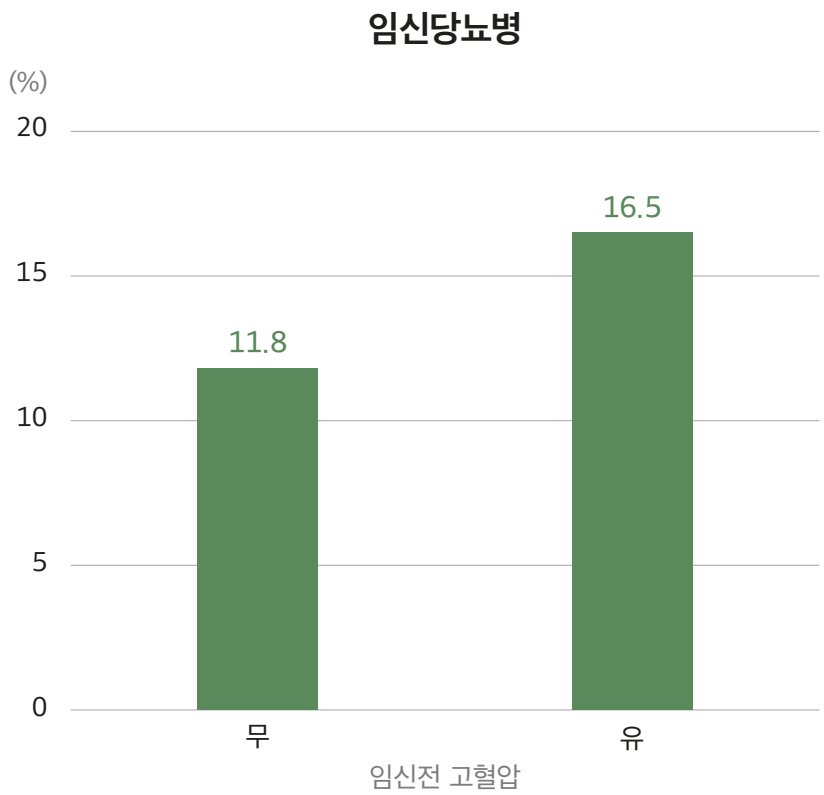
공복혈당에 따른 임신당뇨병 유병률

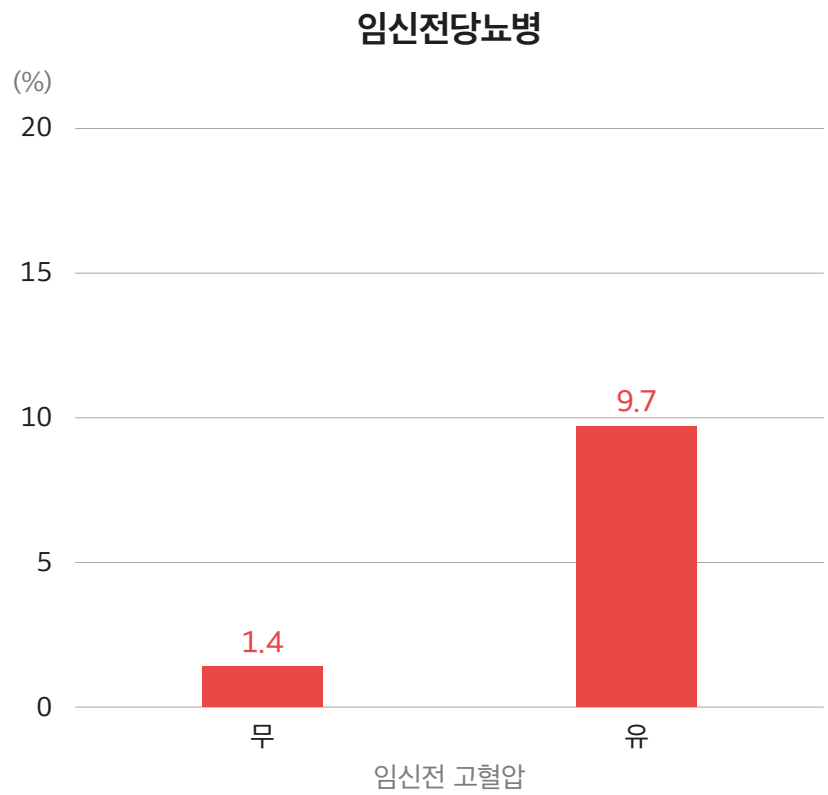
임신전 공복혈당이 증가함에 따라 임신당뇨병의 유병률이 증가함.



임신전 고혈압에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

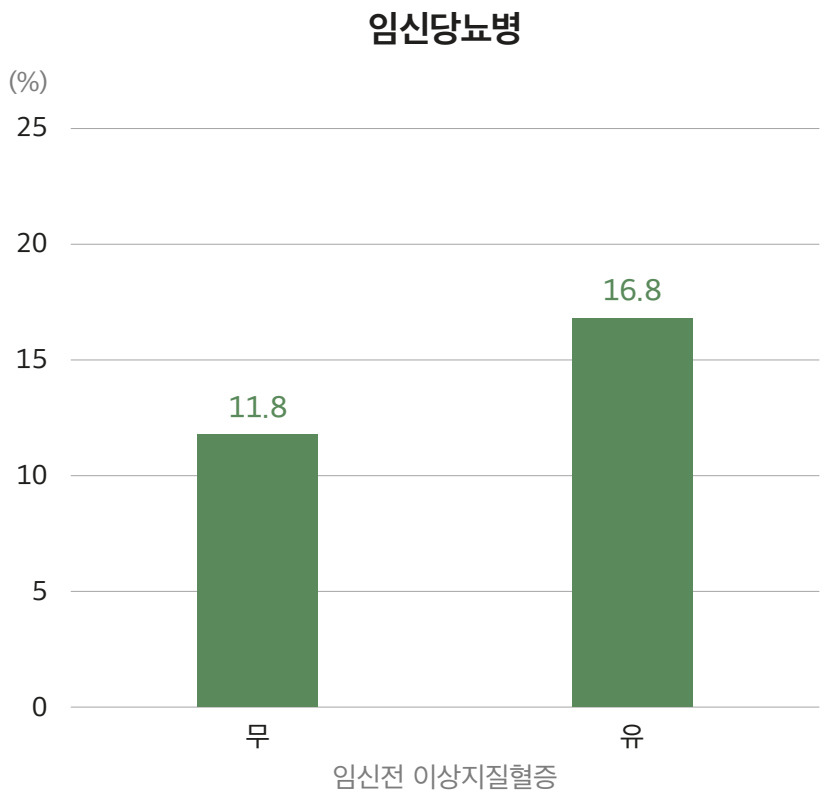
임신전 고혈압이 있는 경우 임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 유병률이 더 높음.
임신전 고혈압을 동반한 산모의 6명 중 1명이 임신당뇨병을 동반하며, 10명 중 1명이 임신전당뇨병을 동반함.

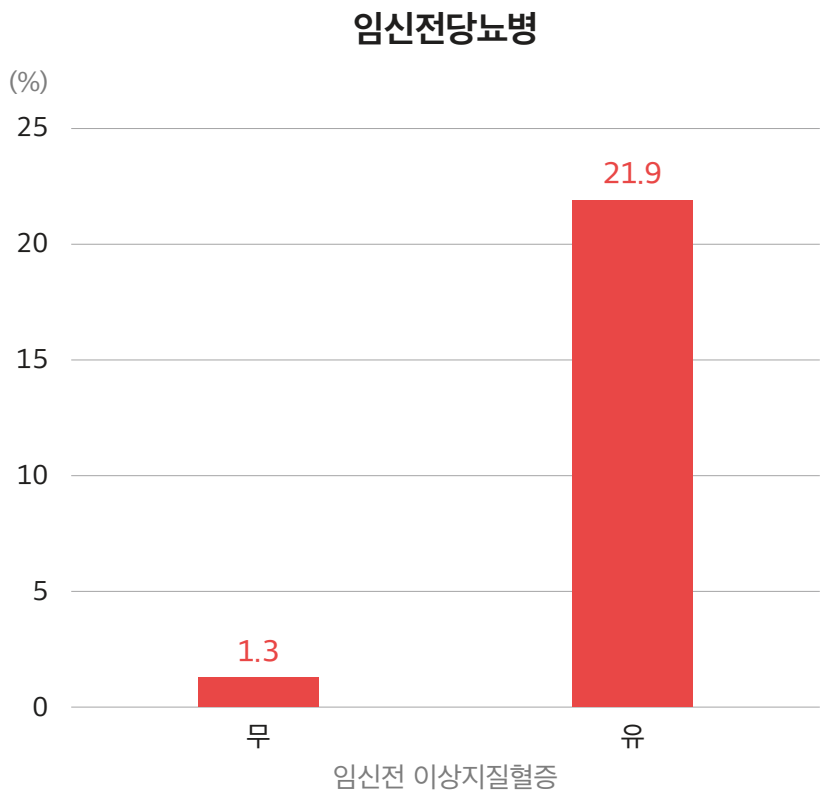




임신전 이상지질혈증에 따른 임신당뇨병/임신전당뇨병 유병률

임신전 이상지질혈증이 있는 경우 임신당뇨병 및 임신전당뇨병의 유병률이 더 높음.
임신전 이상지질혈증을 동반한 산모의 6명 중 1명이 임신당뇨병을 동반하며, 5명 중 1명이 임신전당뇨병을 동반함.





임신중당뇨병 산모의 출산후 당뇨병 추적관리 및 합병증

PREGNANCY

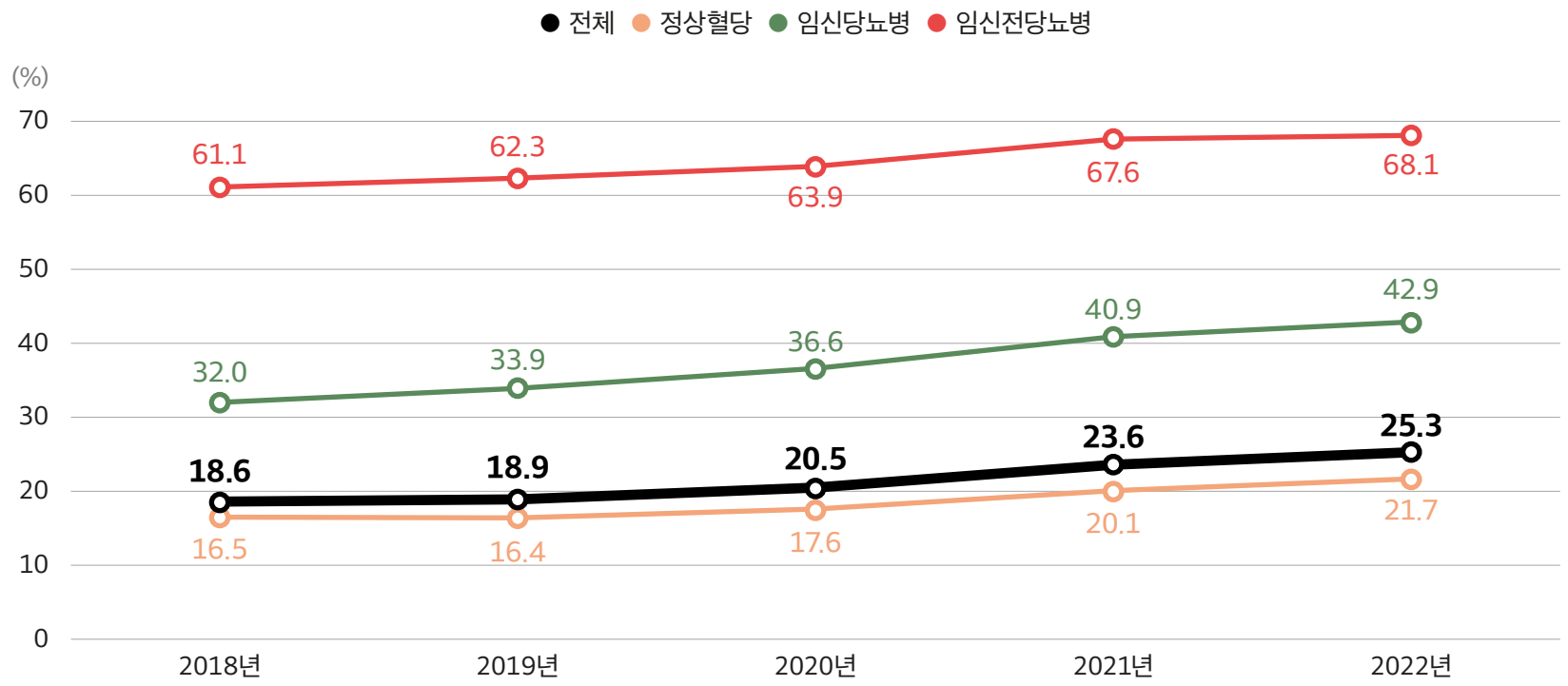
V

출산후 당뇨병 추적검사 시행률

출산후 2형당뇨병 및 심뇌혈관질환 발생위험

출산후 당뇨병 추적검사 시행률

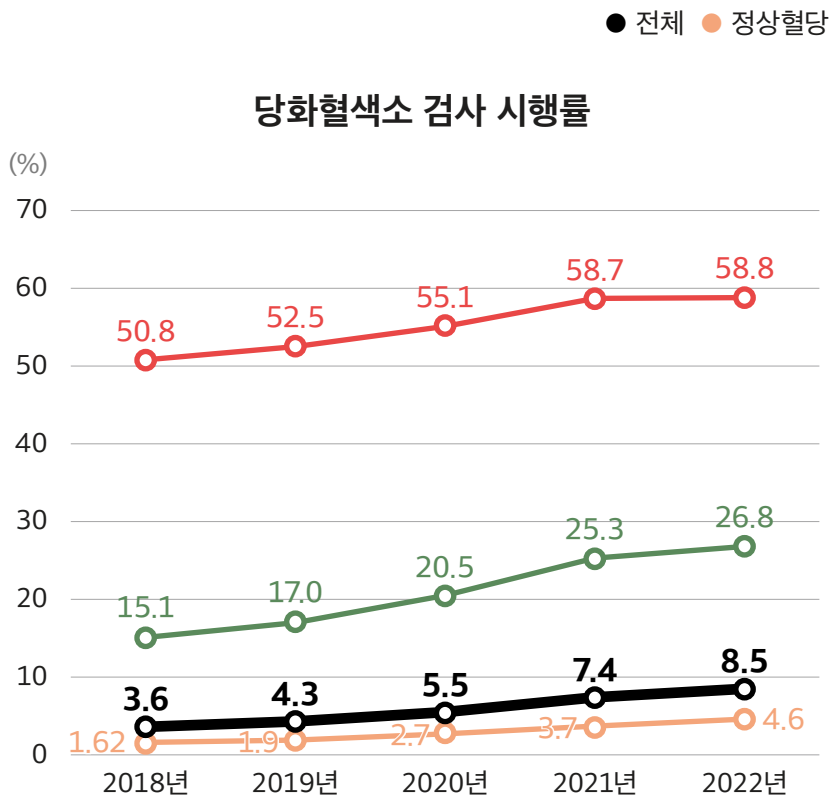
출산후 당뇨병 추적검사 시행률이 증가추세이지만, 임신당뇨병 산모의 절반 이상은 추적검사를 시행하지 않음.
임신전당뇨병 산모의 3명 중 1명에서도 추적검사를 시행하지 않음.

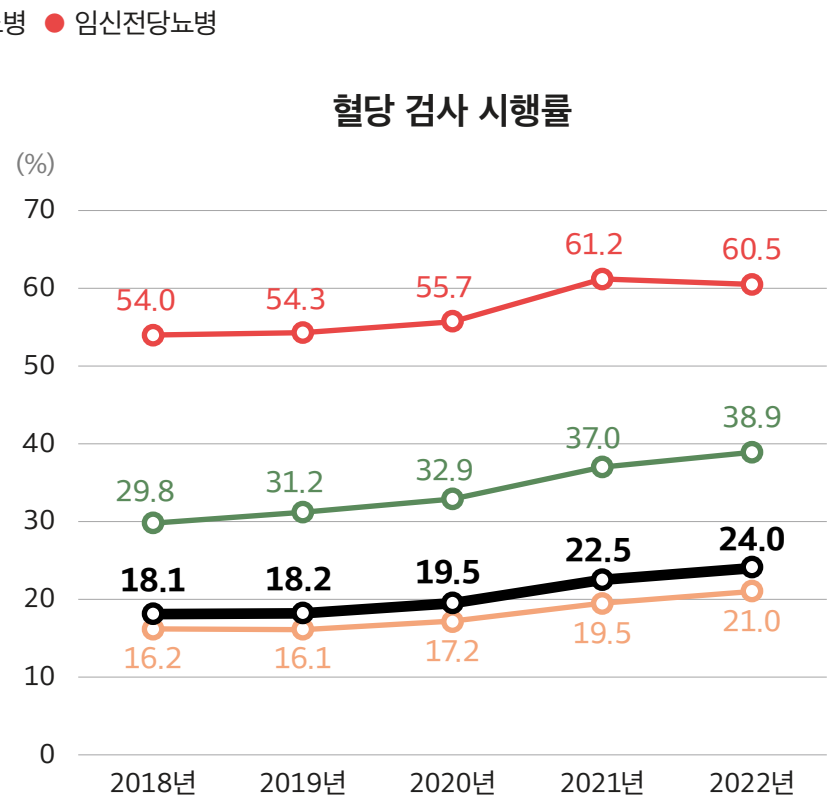


출산후 4주-1년 사이 당화혈색소 혹은 혈당 검사 시행 비율

출산후 당뇨병 추적검사 시행률 (항목별)

임신당뇨병 산모의 4명 중 1명, 임신전당뇨병 산모의 절반 가량에서 출산후 당화혈색소를 추적함.

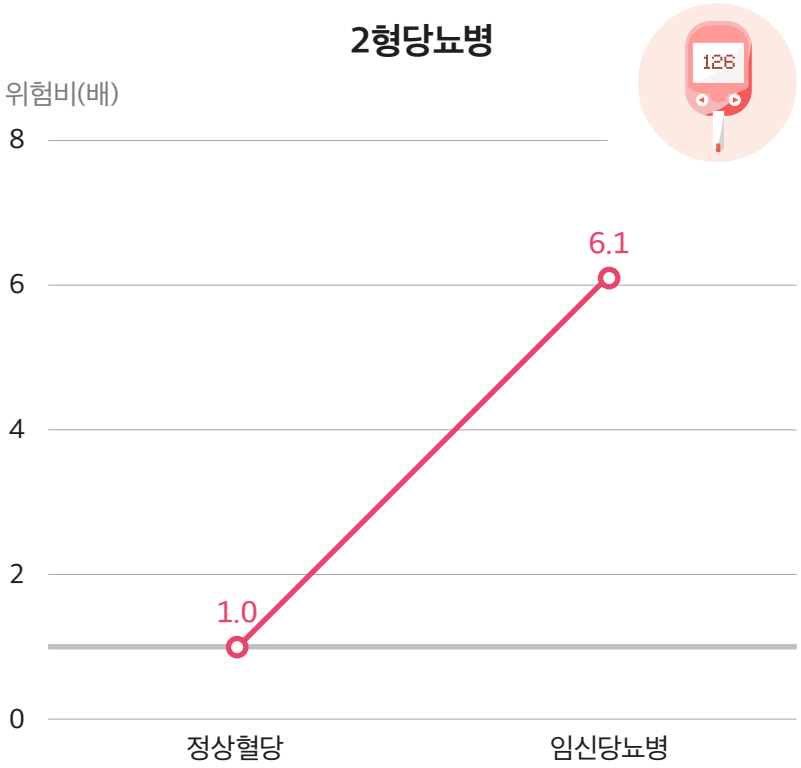


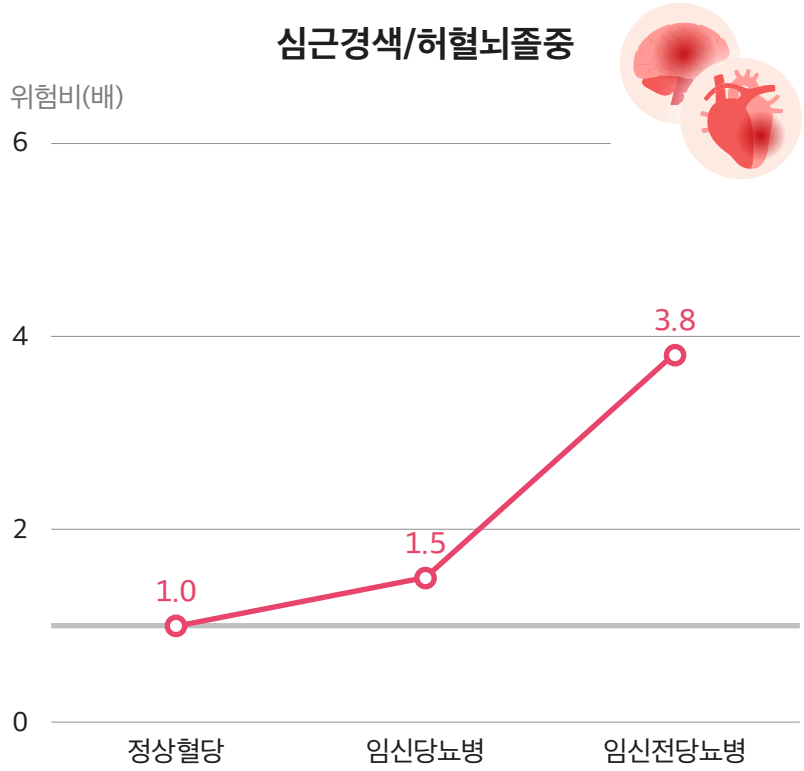


출산후 4주-1년 사이 당화혈색소 혹은 혈당 검사 시행 비율

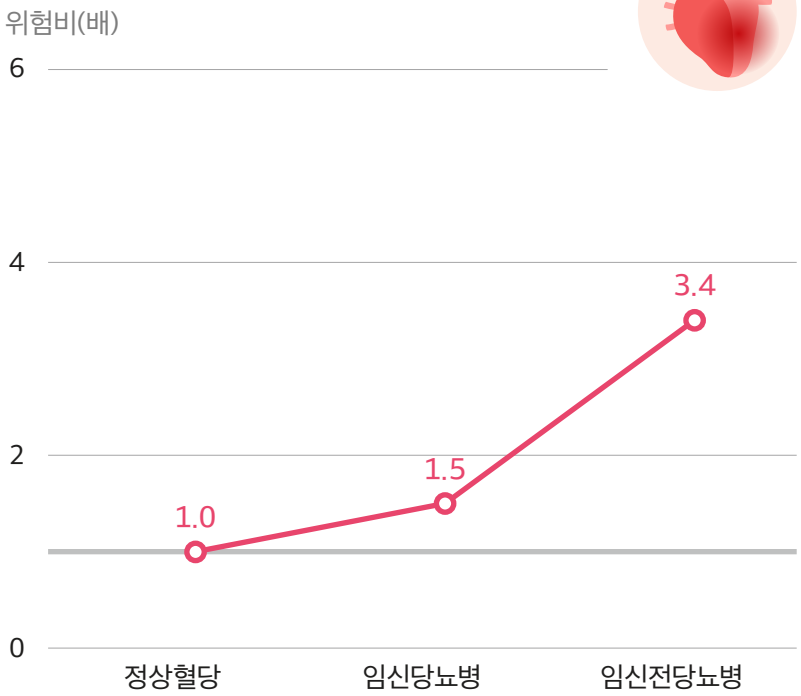
출산후 2형당뇨병 및 심뇌혈관질환 발생위험

출산후 2형당뇨병의 위험은 정상혈당 산모에 비해 임신당뇨병에서 6.1배 증가함.
출산후 심뇌혈관질환의 위험은 정상혈당 산모에 비해 임신당뇨병에서 1.5배, 임신전당뇨병에서 3.8배 증가함.

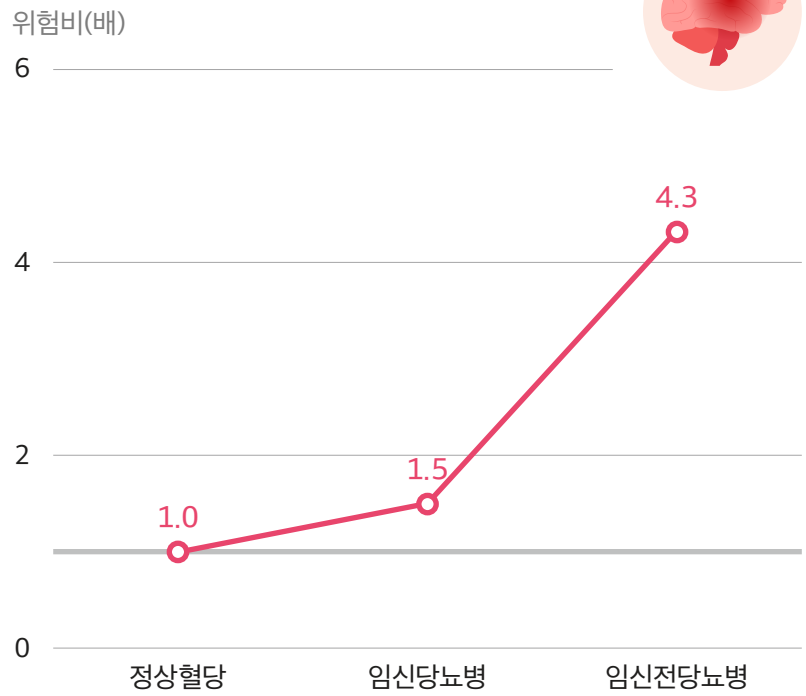




심근경색


위험비(배)
6
4
2
0
1.0
1.5
3.4
정상혈당
임신당뇨병
임신전당뇨병

허혈뇌졸중


위험비(배)
6
4
2
0
1.0
1.5
4.3
정상혈당
임신당뇨병
임신전당뇨병